E-MODUL

EDUKASI PROMOSI KESEHATAN

Disusun oleh:

Nurul Aliyah, S.K.M., M.K.M

Kartika Putri Septiyani, S.K.M., MPH

JURUSAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2026

PRAKATA

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan modul mata kuliah *Edukasi Promosi Kesehatan* ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan yang kami miliki.

Modul ini disusun sebagai salah satu bahan ajar yang bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam memahami konsep, prinsip, serta penerapan edukasi dalam promosi kesehatan. Kami berharap modul ini dapat menambah wawasan, memperkuat pemahaman, serta menjadi panduan dalam proses pembelajaran, baik secara teori maupun praktik di bidang promosi kesehatan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa modul ini masih memiliki berbagai kekurangan dan belum sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan modul ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami berharap modul ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, tenaga pendidik, maupun pembaca lainnya dalam mendukung peningkatan pengetahuan dan kompetensi di bidang promosi kesehatan. Kami juga memohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyusunan modul ini.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR GAMBAR ix

BAB I. 1

PENDAHULUAN 1

A. Deskripsi Mata Kuliah 1

B. Petunjuk Masuk ke Kuliah Online 1

C. Petunjuk Mendownload Materi Kuliah 2

D. Langkah Mengikuti Kuis Online 3

E. Langkah Mengikuti Tugas Online 4

F. Langkah Mengikuti Forum Diskusi 4

G. Ketentuan Lain 4

BAB II 5

KONSEP EDUKASI DAN MEDIA PROMOSI KESEHATAN 5

A. Edukasi Promosi Kesehatan Sebagai Bagian Dari Promosi Kesehatan 5

B. Pengertian Edukasi Promosi Kesehatan 5

C. Tujuan Edukasi Promosi Kesehatan 6

D. Jenis dan Metode Edukasi Promosi Kesehatan 7

E. Media dalam Edukasi Promosi Kesehatan 8

F. Latihan / Evaluasi 23

BAB III 24

MENDENGARKAN AKTIF DAN BERPIKIR KRITIS 24

A. Konsep Hearing dan Listening 24

B. Konsep Mendengarkan Aktif 24

C. Jenis dan Prinsip Mendengarkan 25
D. Teknik Mendengarkan Aktif 25
E. Hambatan dalam Mendengarkan 25
F. Konsep Berpikir Kritis 26
G. Manfaat dan Pengembangan Berpikir Kritis 26
H. Penerapan dalam Kesehatan Masyarakat 27
I. Rangkuman 29
J. Latihan / Evaluasi 29
BAB IV 30
KOMUNIKASI VERBAL DAN NON VERBAL 30
A. Konsep Komunikasi Kesehatan 30
B. Komunikasi Verbal 31
1. Pengertian 31
C. Komunikasi Nonverbal 32
D. Jenis Komunikasi Nonverbal 33
E. Hubungan Komunikasi Verbal dan Nonverbal 36
F. Rangkuman 37
G. Latihan / Evaluasi 37
BAB V 38
TEORI TENTANG KONSELING 38
A. Konsep Konseling 38
B. Tujuan Konseling dalam Promosi Kesehatan 38
C. Konseling dalam Perubahan Perilaku 38
D. Prinsip Konseling 39
E. Ruang Lingkup Konseling 39
F. Teori-Teori Konseling 40

G. Tokoh-Tokoh Konseling 41
H. Penerapan Konseling dalam Promosi Kesehatan 41
I. Rangkuman 42
J. Latihan / Evaluasi 42
BAB VI 43
ETIKA KONSELING 43
A. Pengertian dan Pentingnya Etika Konseling 43
B. Fungsi Etika sebagai Perlindungan Klien 43
C. Peran Etika dalam Hubungan Terapeutik 43
D. Prinsip-Prinsip Etika Konseling 44
E. Kode Etik Konselor 44
F. Hak dan Kewajiban dalam Konseling 45
G. Pelanggaran Etika dan Tanggung Jawab Profesional 45
H. Sensitivitas Budaya dalam Konseling 46
I. Rangkuman 47
J. Latihan / Evaluasi 47
BAB VII 48
KONSEP MOTIVATIONAL INTERVIEWING (MI) 48
A. Latar Belakang *Motivational Interviewing* 48
B. Definisi *Motivational Interviewing* 48
C. Prinsip Dasar Motivational Interviewing 49
D. Teknik OARS 49
E. Change Talk dan Sustain Talk 50
F. Model DARN-CAT 50
G. Tahapan Proses Motivational Interviewing 51
H. Rangkuman 51

I. Latihan / Evaluasi 51
BAB VIII 52
TEKNIK REFLEKSI DAN PARAFRASE 52
A. Konsep Refleksi dan Parafrase 52
B. Landasan Teoretis 52
C. Teknik Refleksi 53
D. Fungsi Refleksi 54
E. Teknik Parafrase 55
F. Fungsi Parafrase 56
BAB IX 57
TEKNIK MEMBANGUN RELASI INTERPERSONAL 57
A. Konsep dan Pentingnya Relasi Interpersonal 57
B. Karakteristik Relasi Interpersonal 57
C. Prinsip Dasar Relasi Interpersonal 58
D. Teknik Membangun Relasi Interpersonal 58
E. Tahapan Membangun Relasi Interpersonal 59
F. Faktor Pendukung dan Penghambat 59
G. Penerapan dalam Promosi Kesehatan 60
H. Rangkuman 60
I. Latihan / Evaluasi 60
BAB X 62
KOMUNIKASI PERSUASIF 62
A. Konsep Komunikasi Persuasif 62
B. Prinsip Dasar Komunikasi Persuasif 62
C. Teknik-Teknik Komunikasi Persuasif 63
D. Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Persuasi 64

E. Rangkuman 65
F. Latihan / Evaluasi 65
BAB XI 66
TEORI PERUBAHAN PERILAKU KESEHATAN 66
A. Konsep Perubahan Perilaku 66
B. Teori Perubahan Perilaku 67
C. Strategi Promosi Kesehatan 68
D. Rangkuman 69
E. Latihan / Evaluasi 69
BAB XIII 70
A. Konsep Kelompok Rentan Dalam Kesehatan Masyarakat 70
B. Faktor Kerentanan (Sosial, Ekonomi, Kesehatan, Stigma) 70
C. Prinsip Komunikasi pada Kelompok Rentan 71
D. Strategi Komunikasi pada Beberapa Kelompok Rentan 72
E. Contoh Kasus Pendekatan Verbal dalam Edukasi Promosi Kesehatan 72
F. Rangkuman 73
G. Latihan / Evaluasi 73
BAB XIV 74
APLIKASI EDUKASI DAN KONSELING DALAM PROMOSI KESEHATAN 74
A. Orientasi Aplikasi Edukasi dan Konseling 74
B. Tahap Persiapan 74
C. Tahap Pelaksanaan 75
D. Prinsip Pelaksanaan 75
E. Langkah Operasional Pelaksanaan 76
F. Hal yang Harus Dihindari 76
G. Evaluasi Kegiatan 77

H. Indikator Keberhasilan 77

I. Rangkuman 77

J. Latihan / Evaluasi 77

BAB XV 78

CONTOH SOAL BESERTA JAWABAN 78

DAFTAR PUSTAKA 79

LAMPIRAN 81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tampilan Pencarian Elearning Edukasi Promosi Kesehatan 2
Gambar 1. 2 Tampilan Elearning Edukasi Promosi Kesehatan 2
Gambar 1. 3 Pilih PPT yang akan diunduh 3
Gambar 1. 4 Langkah Mengikuti Forum Diskusi 4
Gambar 2. 1 Ilustrasi Poster 10
Gambar 2. 2 Ilustrasi Pamflet 10
Gambar 2. 3 Ilustrasi Leaflet 11
Gambar 2. 4 Ilustrasi Booklet 11
Gambar 2. 5 Ilustrasi Flyer 12
Gambar 2. 6 Ilustrasi Spanduk 12
Gambar 2. 7 Ilustrasi Billboard 13
Gambar 2. 8 Ilustrasi Flipchart 13
Gambar 2. 9 Ilustrasi Televisi 14
Gambar 2. 10 Ilustrasi Radio 15
Gambar 2. 11 Ilustrasi Video Pendek 15
Gambar 2. 12 Ilustrasi PowerPoint 16
Gambar 2. 13 Ilustrasi Infografis Digital 16
Gambar 2. 14 Ilustrasi Kaset atau Rekaman Audio 17
Gambar 2. 15 Ilustrasi Media Visual Tanpa Proyeksi 18
Gambar 2. 16 Ilustrasi Media Visual dengan Proyeksi 19
Gambar 2. 17 Ilustrasi Media Audio (*Audio Aids*) 20
Gambar 2. 18 Ilustrasi Media Audio-Visual 21
Gambar 3. 1 Ilustrasi Jenis Komunikasi Nonverbal Kinesik 33
Gambar 3. 2 Ilustrasi Jenis Komunikasi Nonverbal Okulasik 34
Gambar 3. 3 Ilustrasi Jenis Komunikasi Nonverbal Haptik 34
Gambar 3. 4 Ilustrasi Jenis Komunikasi Nonverbal Proksemik 35

BAB I.
PENDAHULUAN

A. Deskripsi Mata Kuliah

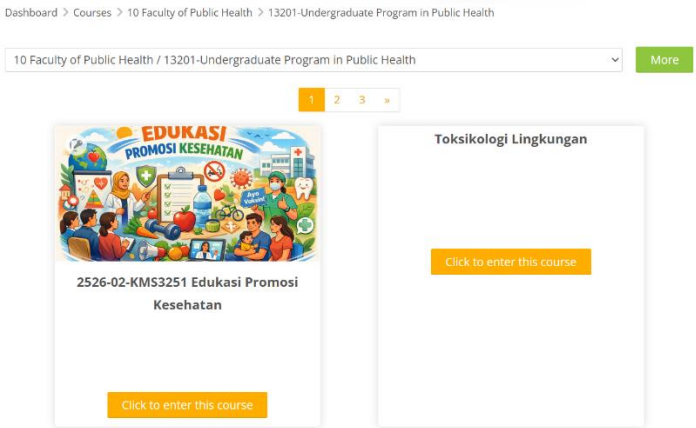
Mata kuliah *Edukasi Promosi Kesehatan* mempelajari berbagai konsep, metode, dan keterampilan dalam pelaksanaan edukasi di bidang promosi kesehatan. Materi yang dibahas meliputi jenis dan bentuk edukasi kesehatan, penggunaan media edukasi, serta teknik komunikasi dan konseling seperti mendengar aktif, komunikasi non-verbal, refleksi, parafrase, dan klarifikasi. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas penerapan strategi komunikasi untuk perubahan perilaku kesehatan, termasuk penggunaan pendekatan *motivational interviewing* dalam praktik edukasi kepada individu maupun kelompok. Mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan edukasi dan konseling promosi kesehatan secara efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

B. Petunjuk Masuk ke Kuliah Online

Mata kuliah *Edukasi Promosi Kesehatan* dapat diakses melalui platform e-learning universitas. Langkah-langkah untuk mengakses perkuliahan online adalah sebagai berikut:

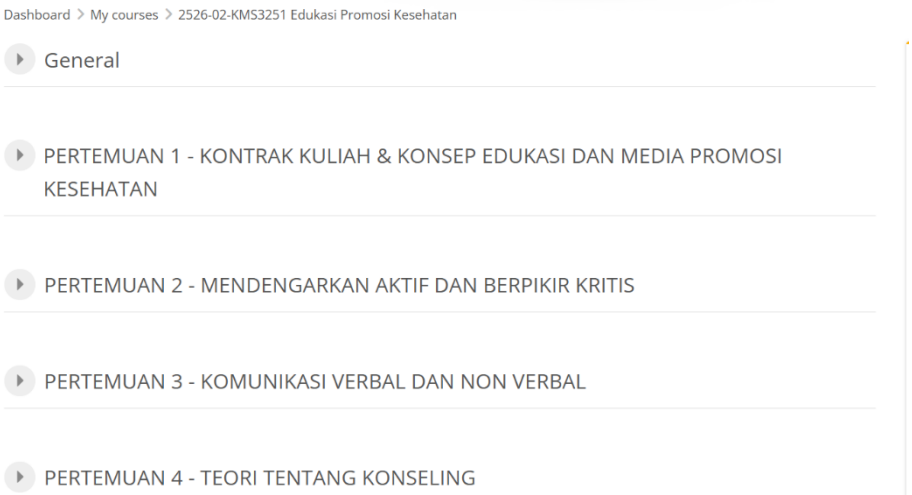
1. Buka website e-learning: **www.elearning.unsri.ac.id**
2. Login menggunakan akun mahasiswa yang telah terdaftar.
3. Pilih menu **Courses**.
4. Masuk ke **Faculty of Public Health**.
5. Pilih program studi **S-1 Kesehatan Masyarakat**.

6. Pilih mata kuliah **Edukasi Promosi Kesehatan**.



Gambar 1. 1 Tampilan Pencarian Elearning Edukasi Promosi Kesehatan

7. Masukkan **password/enrollment key** yang diberikan oleh dosen pengampu.



Gambar 1. 2 Tampilan Elearning Edukasi Promosi Kesehatan

C. Petunjuk Mendownload Materi Kuliah

Materi pembelajaran tersedia dalam bentuk file seperti PPT, PDF, maupun dokumen lainnya. Langkah untuk mengunduh materi:

1. Masuk ke halaman mata kuliah pada e-learning.
2. Pilih pertemuan atau topik yang diinginkan.

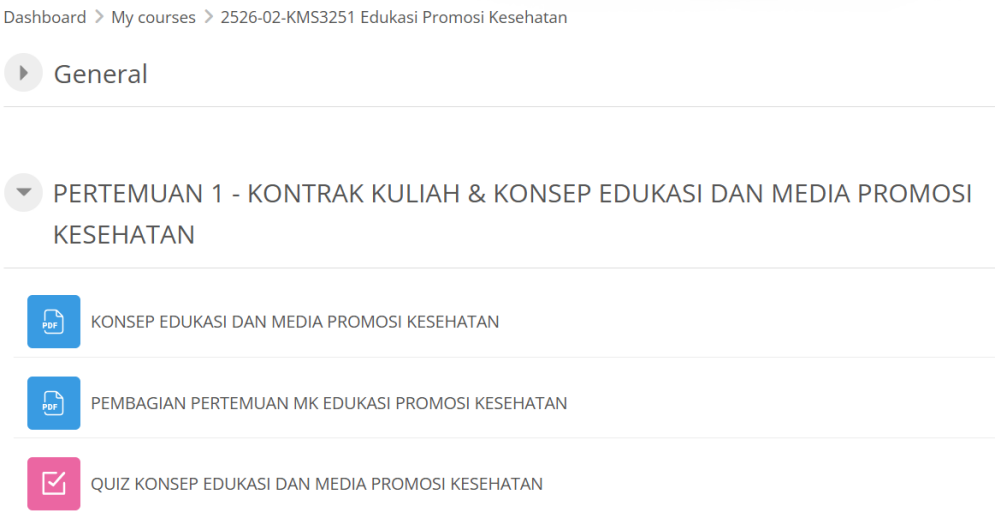
Gambar 1. 3 Pilih PPT yang akan diunduh

3. Klik pada menu atau file **Materi Pembelajaran**.
4. File akan otomatis terunduh atau terbuka untuk diunduh.

D. Langkah Mengikuti Kuis Online

Kuis digunakan untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari. Langkah mengikuti kuis:

1. Masuk ke halaman mata kuliah.
2. Pilih menu **Kuis Pembelajaran** pada pertemuan terkait.



3. Klik **Preview Quiz** atau **Attempt Quiz**.
4. Kerjakan soal sesuai waktu yang ditentukan.
5. Klik **Submit** setelah selesai.

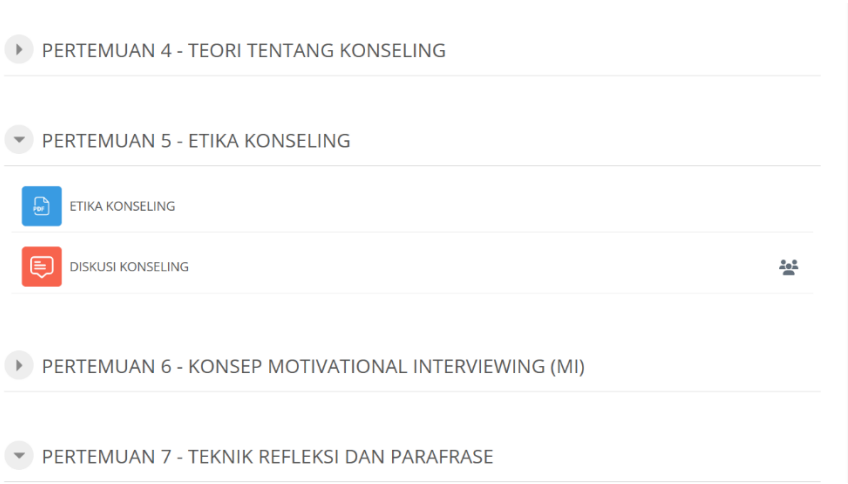
E. Langkah Mengikuti Tugas Online

Tugas diberikan untuk melatih kemampuan analisis dan penerapan materi. Langkah mengerjakan tugas:

1. Pilih menu **Tugas** pada pertemuan yang ditentukan.
2. Baca instruksi tugas dengan seksama.
3. Klik **Add Submission** atau **Unggah Tugas**.
4. Upload file sesuai format yang diminta.
5. Klik **Submit** untuk mengirim tugas.

F. Langkah Mengikuti Forum Diskusi

Forum diskusi digunakan sebagai sarana interaksi antara mahasiswa dan dosen. Langkah mengikuti forum:



Gambar 1. 4 Langkah Mengikuti Forum Diskusi

1. Masuk ke menu **Forum Diskusi** pada pertemuan terkait.
2. Pilih topik diskusi yang tersedia.
3. Klik **Add a new discussion** atau **Reply**.
4. Tuliskan pendapat atau pertanyaan.
5. Kirim dengan klik **Post to forum**.

G. Ketentuan Lain

1. Mahasiswa diwajibkan mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran secara aktif.
2. Kehadiran dan partisipasi dalam diskusi menjadi bagian dari penilaian.
3. Setiap tugas dan kuis harus dikumpulkan sesuai batas waktu yang ditentukan.
4. Mahasiswa diharapkan menjaga etika komunikasi dalam pembelajaran daring.

BAB II
KONSEP EDUKASI DAN MEDIA PROMOSI KESEHATAN

A. Edukasi Promosi Kesehatan Sebagai Bagian Dari Promosi Kesehatan

Dalam perspektif promosi kesehatan, edukasi bukan sekadar kegiatan penyampaian informasi, melainkan merupakan strategi intervensi perilaku yang bertujuan memberdayakan individu dan masyarakat agar mampu mengendalikan faktor-faktor yang memengaruhi kesehatannya. Promosi kesehatan menempatkan manusia sebagai subjek aktif yang memiliki kapasitas untuk membuat keputusan kesehatan secara mandiri. Menurut World Health Organization, promosi kesehatan adalah proses yang memungkinkan masyarakat meningkatkan kontrol terhadap determinan kesehatan dan dengan demikian meningkatkan kesehatannya (WHO, 1986). Determinan kesehatan tersebut meliputi faktor perilaku, lingkungan, sosial, ekonomi, dan kebijakan. Dalam kerangka ini, edukasi promosi kesehatan berfungsi untuk:

1. meningkatkan literasi kesehatan (health literacy),
2. membangun kesadaran kritis terhadap faktor risiko,
3. serta mendorong perubahan perilaku secara sukarela dan berkelanjutan.

Dengan demikian, edukasi dalam promosi kesehatan tidak hanya berorientasi pada individu, tetapi juga berkaitan erat dengan perubahan lingkungan sosial dan budaya yang mendukung perilaku sehat.

B. Pengertian Edukasi Promosi Kesehatan

Edukasi promosi kesehatan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam promosi kesehatan. Dalam konteks kesehatan masyarakat, promosi kesehatan tidak hanya dimaknai sebagai upaya menyampaikan informasi kepada masyarakat, melainkan sebagai proses yang memungkinkan individu dan kelompok meningkatkan kemampuan untuk mengendalikan faktor-faktor yang memengaruhi kesehatannya. World Health Organization melalui *Ottawa Charter for Health Promotion* menegaskan bahwa promosi kesehatan adalah proses yang memungkinkan masyarakat meningkatkan kontrol atas kesehatannya dan dengan demikian memperbaiki derajat kesehatannya (WHO, 1986).

Edukasi promosi kesehatan merupakan proses pembelajaran yang dirancang secara sistematis untuk memengaruhi determinan perilaku kesehatan, yaitu pengetahuan, sikap, norma sosial, serta keterampilan individu dalam mengambil keputusan terkait kesehatan. Notoatmodjo menyatakan bahwa pendidikan kesehatan adalah upaya untuk memengaruhi individu atau masyarakat agar berperilaku sehat (Notoatmodjo, 2012). Sementara itu, Green dan Kreuter menekankan bahwa perubahan perilaku dipengaruhi oleh faktor predisposisi (pengetahuan dan sikap), faktor pendukung (sarana dan prasarana), serta faktor penguat (dukungan sosial dan kebijakan) (Green & Kreuter, 2005). Oleh karena itu, edukasi promosi kesehatan harus mempertimbangkan ketiga faktor tersebut. Edukasi yang hanya memberikan informasi tanpa didukung lingkungan dan kebijakan yang kondusif cenderung tidak efektif dalam menghasilkan perubahan perilaku.

C. Tujuan Edukasi Promosi Kesehatan

Tujuan edukasi dalam promosi kesehatan tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi lebih jauh bertujuan menghasilkan perubahan perilaku kesehatan yang berkelanjutan. Dalam kerangka promosi kesehatan, tujuan edukasi mencakup:

1. Peningkatan literasi Kesehatan

   Edukasi membantu masyarakat memahami informasi kesehatan sehingga mampu membuat keputusan yang tepat.
2. Perubahan sikap dan norma sosial

   Edukasi mendorong terbentuknya nilai dan norma yang mendukung perilaku sehat, misalnya norma tidak merokok di lingkungan keluarga.
3. Penguatan keterampilan hidup sehat (life skills)

   Individu dilatih untuk mampu mempraktikkan perilaku sehat, seperti memilih makanan bergizi atau menjaga kebersihan lingkungan.
4. Pemberdayaan masyarakat (empowerment)

   Edukasi bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi masalah kesehatan, mencari solusi, dan bertindak secara mandiri.

Bloom (1956) menjelaskan bahwa perubahan perilaku mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor yang harus dikembangkan secara terpadu..

D. Jenis dan Metode Edukasi Promosi Kesehatan

1. Edukasi Berdasarkan Sasaran: Individu, Kelompok, dan Massal

Dalam promosi kesehatan, pemilihan sasaran edukasi sangat penting karena berkaitan dengan efektivitas intervensi. Sasaran dapat berupa individu, kelompok, maupun masyarakat luas, yang masing-masing membutuhkan pendekatan berbeda.

1) Edukasi individu digunakan untuk intervensi perubahan perilaku spesifik, seperti kepatuhan minum obat atau pengelolaan penyakit kronis. Pendekatan ini bersifat personal dan memungkinkan eksplorasi faktor psikologis serta sosial yang memengaruhi perilaku.
2) Edukasi kelompok merupakan pendekatan yang sering digunakan dalam promosi kesehatan berbasis komunitas. Melalui kelompok, terjadi proses pembelajaran sosial (social learning), di mana individu belajar dari pengalaman orang lain. Pendekatan ini efektif dalam membentuk norma sosial yang mendukung perilaku sehat.
3) Edukasi massal bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat secara luas. Dalam promosi kesehatan, edukasi massal sering dikaitkan dengan strategi advokasi dan kampanye kesehatan, misalnya kampanye anti-rokok atau imunisasi.

Namun, untuk menghasilkan perubahan perilaku yang mendalam, edukasi massal perlu dikombinasikan dengan pendekatan komunitas.

2. Metode Edukasi: Penyuluhan, Diskusi, dan Konseling

Metode edukasi promosi kesehatan tidak hanya dipilih berdasarkan kemudahan penyampaian, tetapi juga berdasarkan kemampuannya dalam memengaruhi perilaku.

1) Metode penyuluhan (ceramah) umumnya digunakan untuk meningkatkan pengetahuan. Namun, dalam promosi kesehatan modern, metode ini perlu dikombinasikan dengan pendekatan partisipatif agar tidak bersifat satu arah.
2) Metode diskusi merupakan metode yang sangat dianjurkan dalam promosi kesehatan karena mendorong partisipasi aktif dan refleksi kritis. Diskusi memungkinkan individu mengaitkan informasi dengan

pengalaman hidup mereka, sehingga lebih bermakna.

3) Metode konseling digunakan untuk membantu individu mengatasi hambatan perilaku dan mengambil keputusan kesehatan. Pendekatan ini sangat penting dalam intervensi perilaku berisiko, seperti berhenti merokok atau kepatuhan pengobatan.
4) Metode demonstrasi dan praktik langsung sangat efektif dalam meningkatkan keterampilan. Dalam promosi kesehatan, perubahan perilaku akan lebih mudah terjadi jika individu tidak hanya mengetahui, tetapi juga mampu melakukan.

Dale menyatakan bahwa pengalaman langsung memberikan dampak belajar yang lebih kuat dibandingkan metode verbal (Dale, 1969).

3. Pendekatan Edukasi: Promotif, Preventif

Dalam pelaksanaannya, edukasi promosi kesehatan juga dapat dibedakan berdasarkan pendekatan, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pendekatan promotif berfokus pada upaya meningkatkan kesehatan, misalnya melalui edukasi tentang gizi seimbang, aktivitas fisik, atau manajemen stres. Pendekatan preventif bertujuan mencegah timbulnya penyakit, misalnya edukasi tentang imunisasi, sanitasi lingkungan, atau perilaku hidup bersih dan sehat.

E. Media dalam Edukasi Promosi Kesehatan

1. Pengertian Media Sebagai Alat Penyampaian Pesan Kesehatan

Secara umum, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran sehingga dapat merangsang terjadinya proses belajar. Kata *media* berasal dari bahasa Latin *medius* yang berarti perantara. Dalam promosi kesehatan, media bukan hanya alat bantu, tetapi merupakan bagian dari strategi komunikasi untuk memengaruhi perilaku masyarakat.

Media digunakan untuk:

1) meningkatkan awareness,
2) memperkuat pesan kesehatan,
3) membentuk persepsi dan sikap,
4) serta mendorong tindakan.

Menurut Sadiman, media pembelajaran dapat merangsang pikiran, perasaan, dan minat belajar (Sadiman et al., 2011). Dalam promkes, media juga berfungsi sebagai alat perubahan sosial.

2. Jenis media:

1) Klasifikasi Media Pembelajaran Berdasarkan Bentuk atau Teknologi

- **Media Cetak**

  Media cetak adalah media pembelajaran yang menyajikan informasi melalui tulisan, gambar, simbol, atau kombinasi ketiganya yang dicetak pada bahan fisik seperti kertas atau kain. Media ini termasuk media yang paling sederhana dan banyak digunakan dalam kegiatan pembelajaran maupun penyuluhan.

  Media cetak berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi secara tertulis dan visual yang dapat membantu audiens memahami materi melalui bacaan yang dapat dipelajari berulang. Media ini juga berperan sebagai dokumentasi pembelajaran serta mendukung kegiatan belajar mandiri. Kelebihan media cetak antara lain mudah dibuat dan digunakan, biaya relatif terjangkau, dapat dibaca kapan saja dan di mana saja, serta tidak memerlukan listrik atau perangkat tambahan. Namun, media cetak memiliki beberapa kekurangan, yaitu kurang interaktif, bergantung pada kemampuan membaca audiens, serta tidak mampu menampilkan unsur suara dan gerak.

  - **Poster**

    Poster adalah media cetak berupa perpaduan gambar dan tulisan singkat yang dirancang menarik untuk menyampaikan pesan tertentu secara cepat.

    Fungsi: menarik perhatian, memberikan informasi singkat, dan mengajak audiens melakukan tindakan tertentu.

Gambar 2. 1 Ilustrasi Poster

Contoh: poster tentang pentingnya mencuci tangan yang ditempel di ruang kelas atau fasilitas umum.

- **Pamflet**

  Pamflet adalah lembaran informasi yang berisi penjelasan singkat mengenai suatu topik, program, atau layanan.

  Fungsi: menyebarkan informasi secara praktis kepada masyarakat atau audiens.

  Contoh: pamflet tentang pencegahan penyakit menular yang dibagikan saat kegiatan penyuluhan.

Gambar 2. 2 Ilustrasi Pamflet

- **Leaflet**

  Leaflet adalah media cetak berbentuk selembar kertas yang dilipat menjadi beberapa bagian.

  Fungsi: menyampaikan informasi yang lebih rinci daripada poster namun tetap praktis dibawa.

  Contoh: leaflet tentang pola makan sehat yang

dibagikan kepada siswa atau orang tua.

Gambar 2. 3 Ilustrasi Leaflet

- **Booklet**

  Booklet adalah buku kecil yang berisi informasi lebih lengkap dan sistematis.

  Fungsi: memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai suatu materi.

  Contoh: booklet pembelajaran tentang gizi seimbang atau kesehatan reproduksi remaja.

Gambar 2. 4 Ilustrasi Booklet

- **Flyer**

  Flyer adalah selebaran satu halaman yang memuat informasi singkat, padat, dan menarik.

  Fungsi: promosi atau penyampaian pesan secara cepat.

  Contoh: flyer tentang jadwal seminar pendidikan.

Gambar 2. 5 Ilustrasi Flyer

- **Spanduk**

  Spanduk adalah media cetak berukuran panjang yang biasanya dipasang di tempat umum.

  Fungsi: menyampaikan pesan kepada khalayak luas dalam bentuk tulisan besar.

  Contoh: spanduk ajakan menjaga kebersihan lingkungan sekolah.

Gambar 2. 6 Ilustrasi Spanduk

- **Billboard**

  Billboard adalah media cetak berukuran besar yang dipasang di area strategis.

  Fungsi: menjangkau audiens dalam jumlah besar.

Contoh: billboard kampanye keselamatan berlalu lintas.

➢

Gambar 2. 7 Ilustrasi Billboard

➢ **Flipchart**

Flipchart adalah kumpulan lembaran kertas berukuran besar yang disusun seperti buku dan dapat dibalik halaman demi halaman.

Fungsi: memudahkan presentasi atau penjelasan materi secara bertahap.

Contoh: flipchart yang digunakan saat menjelaskan konsep sederhana dalam workshop atau pelatihan.

Gambar 2. 8 Ilustrasi Flipchart

- **Media Elektronik**

Media elektronik adalah media pembelajaran yang menggunakan perangkat elektronik atau digital dalam penyampaian informasi. Media ini dapat memadukan unsur

suara, gambar, teks, animasi, maupun video sehingga sering kali lebih menarik dan interaktif.

Media elektronik berfungsi untuk menyampaikan informasi secara cepat dan luas dengan memanfaatkan teknologi digital. Media ini mampu menampilkan materi secara dinamis melalui kombinasi suara, gambar, teks, dan animasi sehingga membantu audiens memahami konsep yang bersifat abstrak. Kelebihan media elektronik adalah tampilannya lebih menarik, mampu menjelaskan materi secara lebih konkret, serta dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Akan tetapi, media ini juga memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan perangkat dan listrik, memerlukan keterampilan penggunaan teknologi, serta tidak semua lingkungan memiliki fasilitas yang memadai.

Contoh Media Elektronik:

- **Televisi**

  Televisi adalah media audio-visual yang menampilkan gambar bergerak disertai suara.

  Fungsi: menyampaikan informasi, hiburan, maupun edukasi secara massal.

  Contoh: iklan kesehatan di televisi nasional untuk mendukung informasi jarak jauh.

Gambar 2. 9 Ilustrasi Televisi

- **Radio**

  Radio adalah media audio yang menyampaikan pesan

melalui suara.

Fungsi: menyampaikan informasi, berita, ceramah, atau pembelajaran berbasis audio.

Contoh: siaran radio edukatif tentang bahasa, kesehatan, atau kewarganegaraan.

Gambar 2. 10 Ilustrasi Radio

- **Video Edukatif**

  Video edukatif adalah media pembelajaran berbasis gambar bergerak dan suara yang dirancang untuk tujuan pendidikan.

  Fungsi: menjelaskan proses, konsep, atau keterampilan secara lebih konkret.

  Contoh nyata: video praktikum, video demonstrasi eksperimen, atau video tutorial pembelajaran.

Gambar 2. 11 Ilustrasi Video Pendek

- **PowerPoint**

  PowerPoint merupakan media presentasi digital yang menampilkan teks, gambar, diagram, tabel, dan animasi.

Fungsi: membantu dosen atau guru menyampaikan materi secara terstruktur dan sistematis.

Contoh: presentasi perkuliahan yang memuat ringkasan materi, ilustrasi, dan latihan.

Gambar 2. 12 Ilustrasi PowerPoint

- **Infografis Digital**

  Infografis digital adalah media visual berbasis teknologi yang menggabungkan data, gambar, dan teks secara ringkas.

  Fungsi: menyederhanakan informasi kompleks agar lebih mudah dipahami.

- **Contoh:** infografis tentang statistik pendidikan, tahapan penelitian, atau prosedur praktikum.

Gambar 2. 13 Ilustrasi Infografis Digital

- **Kaset atau Rekaman Audio**

  Kaset merupakan media penyimpanan suara yang digunakan melalui alat pemutar.

  Fungsi: menyampaikan pesan pembelajaran dalam

bentuk rekaman audio.

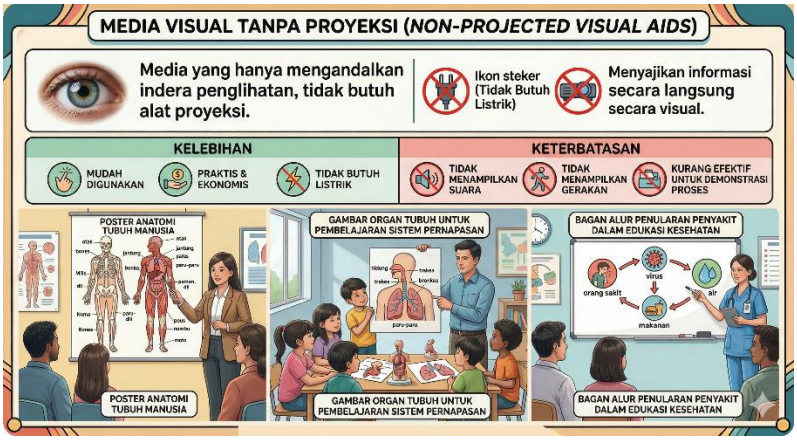
Contoh: rekaman iklan layanan masyarakat.

Gambar 2. 14 Ilustrasi Kaset atau Rekaman Audio

2) **Klasifikasi Media Pembelajaran Berdasarkan Cara Penyampaian**

- **Media Visual Tanpa Proyeksi (*Non-Projected Visual Aids*)**

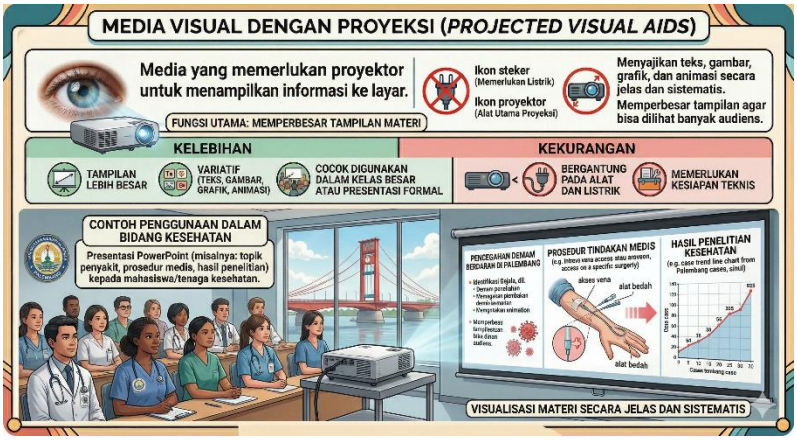
  Media visual tanpa proyeksi adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan dan tidak memerlukan alat proyeksi. Media visual tanpa proyeksi berfungsi untuk menyajikan informasi secara langsung melalui bentuk visual sehingga dapat membantu memperjelas konsep, fakta, atau data serta menarik perhatian audiens. Kelebihan media ini adalah mudah digunakan, tidak membutuhkan listrik, serta praktis dan ekonomis. Namun demikian, media ini memiliki keterbatasan karena tidak dapat menampilkan suara maupun gerakan, sehingga kurang efektif untuk materi yang memerlukan demonstrasi proses. Contoh nyata penggunaan media ini dalam bidang kesehatan adalah poster anatomi tubuh manusia, gambar organ tubuh untuk pembelajaran sistem pencernaan atau pernapasan, serta bagan alur penularan penyakit yang digunakan dalam edukasi kesehatan.



Gambar 2. 15 Ilustrasi Media Visual Tanpa Proyeksi

- **Media Visual dengan Proyeksi (*Projected Visual Aids*)**

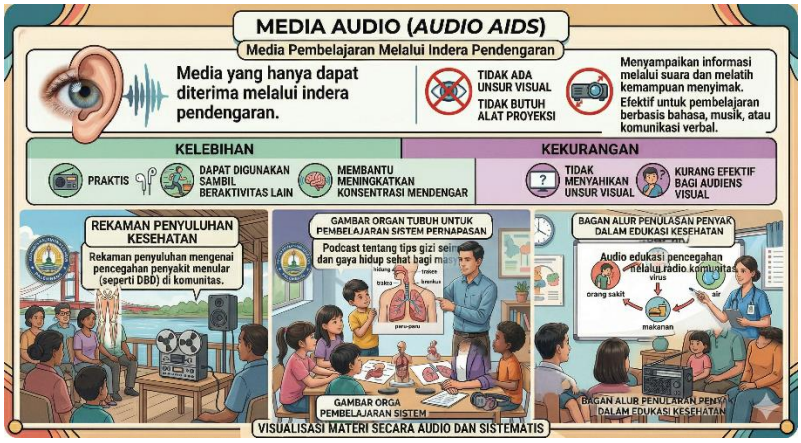
  Media visual dengan proyeksi adalah media yang memerlukan alat bantu proyektor untuk menampilkan informasi ke layar. Media visual dengan proyeksi berfungsi untuk memperbesar tampilan materi sehingga dapat dilihat oleh banyak audiens secara bersamaan. Media ini memungkinkan penyajian teks, gambar, grafik, dan animasi secara lebih jelas dan sistematis. Kelebihannya adalah tampilan lebih besar, variatif, dan cocok digunakan dalam kelas besar atau presentasi formal. Namun, media ini memiliki kekurangan karena bergantung pada alat proyeksi dan listrik serta memerlukan kesiapan teknis. Contoh penggunaannya dalam bidang kesehatan adalah presentasi PowerPoint yang digunakan untuk menjelaskan materi tentang penyakit tertentu, prosedur tindakan medis, atau hasil penelitian kesehatan kepada mahasiswa atau tenaga kesehatan.



Gambar 2. 16 Ilustrasi Media Visual dengan Proyeksi

- **Media Audio (*Audio Aids*)**

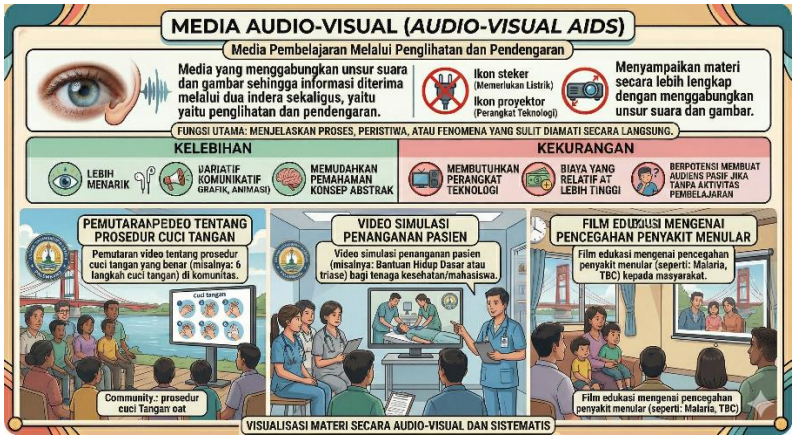
  Media audio adalah media pembelajaran yang hanya dapat diterima melalui indera pendengaran. Media audio berfungsi untuk menyampaikan informasi melalui suara serta melatih kemampuan menyimak audiens. Media ini efektif digunakan dalam pembelajaran berbasis bahasa, musik, atau komunikasi verbal. Kelebihannya adalah praktis, dapat digunakan sambil melakukan aktivitas lain, serta membantu meningkatkan konsentrasi mendengar. Akan tetapi, media ini memiliki kekurangan karena tidak menyajikan unsur visual sehingga kurang efektif bagi audiens yang lebih mudah memahami melalui penglihatan. Contoh nyata penggunaan media audio dalam bidang kesehatan adalah rekaman penyuluhan kesehatan, podcast tentang gaya hidup sehat, atau audio edukasi mengenai pencegahan penyakit yang disampaikan kepada masyarakat.



Gambar 2. 17 Ilustrasi Media Audio (*Audio Aids*)

- **Media Audio-Visual (*Audio-Visual Aids*)**

  Media audio-visual adalah media yang menggabungkan unsur suara dan gambar sehingga informasi diterima melalui dua indera sekaligus, yaitu penglihatan dan pendengaran. Media audio-visual berfungsi untuk menyampaikan materi secara lebih lengkap dengan menggabungkan unsur suara dan gambar sehingga informasi dapat diterima melalui dua indera sekaligus. Media ini sangat efektif untuk menjelaskan proses, peristiwa, atau fenomena yang sulit diamati secara langsung. Kelebihannya adalah lebih menarik, komunikatif, dan memudahkan pemahaman konsep abstrak. Namun, media ini juga memiliki kekurangan karena membutuhkan perangkat teknologi, biaya yang relatif lebih tinggi, serta berpotensi membuat audiens pasif jika tidak disertai aktivitas pembelajaran. Contoh penggunaannya dalam bidang kesehatan adalah pemutaran video tentang prosedur cuci tangan yang benar, video simulasi penanganan pasien, atau film edukasi mengenai pencegahan penyakit menular.



Gambar 2. 18 Ilustrasi Media Audio-Visual

3. Prinsip dan Efektivitas Media Edukasi Promosi Kesehatan

Media dalam promosi kesehatan harus memenuhi prinsip:

1) relevansi dengan sasaran,
2) kesederhanaan pesan,
3) daya tarik visual,
4) serta kesesuaian budaya.

Notoatmodjo menekankan pentingnya kesesuaian media dengan karakteristik sasaran agar pesan dapat diterima secara optimal (Notoatmodjo, 2012). Efektivitas media juga dipengaruhi oleh keterlibatan indera. Semakin banyak indera yang terlibat, semakin tinggi daya ingat terhadap pesan (Dale, 1969).

4. Pengembangan dan Pemilihan Media Edukasi Promosi Kesehatan

Dalam promosi kesehatan, pengembangan media tidak boleh bersifat top-down, tetapi harus melibatkan masyarakat sebagai bagian dari proses. Pendekatan partisipatif memungkinkan media yang dikembangkan lebih sesuai dengan kebutuhan, budaya, dan kondisi lokal. Hal ini akan meningkatkan penerimaan dan efektivitas pesan. Selain itu, media harus mendukung strategi promosi kesehatan lainnya, seperti advokasi kebijakan, penguatan lingkungan, dan kemitraan lintas sektor.

5. Evaluasi Edukasi Promosi Kesehatan

Evaluasi merupakan tahap penting dalam pelaksanaan edukasi promosi kesehatan karena berfungsi untuk menilai keberhasilan kegiatan yang telah

dilakukan. Melalui evaluasi, tenaga kesehatan dapat mengetahui apakah tujuan edukasi telah tercapai serta mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki.

1) Evaluasi edukasi kesehatan mencakup evaluasi proses, hasil, dan dampak.
2) Evaluasi proses menilai bagaimana kegiatan edukasi dilaksanakan, apakah sesuai dengan rencana, dan apakah sasaran terlibat secara aktif.
3) Evaluasi hasil menilai perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan setelah edukasi diberikan.
4) Evaluasi dampak menilai perubahan perilaku jangka panjang serta pengaruhnya terhadap kondisi kesehatan masyarakat.

Metode evaluasi yang dapat digunakan meliputi kuesioner, wawancara, observasi, serta pre-test dan post-test. Green dan Kreuter (2005) menyatakan bahwa evaluasi sangat penting untuk memastikan efektivitas program promosi kesehatan dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan program di masa mendatang.

6. Etika dalam Edukasi Promosi Kesehatan

Etika dalam promosi kesehatan berkaitan dengan penghormatan terhadap hak individu dan nilai sosial masyarakat.

Edukasi harus dilakukan dengan:

1) menghormati otonomi,
2) tidak merugikan,
3) memberikan manfaat,
4) serta menjunjung keadilan.

(Beauchamp & Childress, 2001)

Pendekatan yang empatik dan non-diskriminatif akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program promosi kesehatan.

.Rangkuman

Edukasi promosi kesehatan adalah bagian penting dari promosi kesehatan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap, dan mendorong perilaku hidup sehat agar individu maupun masyarakat mampu menjaga kesehatannya secara mandiri. Pelaksanaannya dapat dilakukan kepada individu, kelompok, maupun

masyarakat luas dengan metode seperti penyuluhan, diskusi, konseling, dan demonstrasi. Keberhasilan edukasi sangat dipengaruhi oleh pemilihan media yang tepat, baik media cetak, elektronik, visual, audio, maupun audio-visual, yang harus disesuaikan dengan karakteristik sasaran, tujuan, dan kondisi lingkungan. Selain itu, edukasi promosi kesehatan perlu dievaluasi untuk menilai proses, hasil, dan dampaknya, serta harus dilaksanakan dengan memperhatikan etika seperti kejujuran, empati, keadilan, dan penghormatan terhadap budaya masyarakat..

F. Latihan / Evaluasi

1. Jelaskan konsep edukasi promosi kesehatan dalam promosi kesehatan!
2. Sebutkan jenis edukasi promosi kesehatan berdasarkan sasaran!
3. Jelaskan fungsi media dalam edukasi promosi kesehatan!
4. Mengapa pemilihan media harus disesuaikan dengan sasaran?
5. Jelaskan pentingnya etika dalam edukasi promosi kesehatan!

BAB III
MENDENGARKAN AKTIF DAN BERPIKIR KRITIS

A. Konsep Hearing dan Listening

Mendengarkan merupakan komponen penting dalam komunikasi kesehatan, khususnya dalam praktik promosi kesehatan yang menekankan interaksi dua arah antara tenaga kesehatan dan masyarakat. Dalam kajian komunikasi, terdapat perbedaan antara hearing dan listening. Hearing merupakan proses fisiologis menerima rangsangan suara secara pasif melalui indera pendengaran, sedangkan listening merupakan proses aktif yang melibatkan perhatian, pemahaman, serta interpretasi terhadap pesan yang diterima (Hargie, 2011). Dalam konteks promosi kesehatan, kemampuan listening sangat penting karena memungkinkan tenaga kesehatan memahami kebutuhan, persepsi, serta masalah kesehatan masyarakat secara lebih mendalam. Dengan demikian, komunikasi yang dilakukan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga responsif terhadap kondisi sasaran.

B. Konsep Mendengarkan Aktif

Mendengarkan aktif (*active listening*) merupakan kemampuan untuk memahami makna pesan sekaligus emosi yang disampaikan oleh pembicara. Dalam praktiknya, mendengarkan aktif tidak hanya berfokus pada isi pesan verbal, tetapi juga memperhatikan bahasa tubuh, intonasi suara, serta konteks komunikasi (Rogers, 1983). Perbedaan utama antara *active listening* dan *passive listening* terletak pada tingkat keterlibatan pendengar. Pada *active listening*, pendengar menunjukkan perhatian penuh, memberikan respons, serta menunjukkan empati terhadap pembicara. Sebaliknya, *passive listening* hanya melibatkan penerimaan informasi tanpa upaya memahami secara mendalam. Dalam promosi kesehatan, mendengarkan aktif menjadi keterampilan esensial karena mendukung pendekatan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Melalui mendengarkan aktif, tenaga kesehatan dapat membangun hubungan yang lebih baik, meningkatkan kepercayaan, serta memahami determinan perilaku kesehatan masyarakat secara komprehensif.

C. Jenis dan Prinsip Mendengarkan

Mendengarkan memiliki beberapa jenis yang digunakan sesuai dengan tujuan komunikasi. *Appreciative listening* dilakukan untuk menikmati pesan, seperti mendengarkan cerita atau musik. *Empathic listening* bertujuan memahami kondisi emosional pembicara. *Comprehensive listening* digunakan untuk memahami informasi secara mendalam, sedangkan *active listening* melibatkan keterlibatan penuh dalam memahami dan merespons pesan (Brownell, 2012) .

Dalam penerapannya, mendengarkan aktif didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu empati, penerimaan, fokus, dan keinginan untuk memahami (Rogers, 1983). Empati memungkinkan pendengar memahami perasaan pembicara, sedangkan penerimaan menuntut sikap tidak menghakimi. Fokus berarti memberikan perhatian penuh tanpa distraksi, dan keinginan untuk memahami menunjukkan adanya motivasi internal untuk menangkap makna pesan secara utuh. Prinsip-prinsip tersebut sangat relevan dalam promosi kesehatan, karena komunikasi yang efektif tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun hubungan interpersonal yang mendukung perubahan perilaku.

D. Teknik Mendengarkan Aktif

Penerapan mendengarkan aktif memerlukan teknik tertentu agar komunikasi berjalan efektif. Salah satu teknik utama adalah memberikan perhatian penuh kepada pembicara melalui kontak mata, ekspresi wajah yang sesuai, serta bahasa tubuh yang terbuka dan responsif (Egan, 2014). Selain itu, penggunaan pertanyaan terbuka dan klarifikasi sangat penting untuk menggali informasi lebih dalam dan menghindari kesalahpahaman. Teknik parafrase dan merangkum juga diperlukan untuk memastikan bahwa pesan telah dipahami dengan benar. Di sisi lain, pendengar harus menghindari perilaku yang mengganggu komunikasi, seperti memotong pembicaraan atau mendominasi percakapan (Hargie, 2011). Dalam promosi kesehatan, teknik-teknik ini membantu tenaga kesehatan memperoleh informasi yang valid dari masyarakat serta meningkatkan efektivitas edukasi kesehatan.

E. Hambatan dalam Mendengarkan

Dalam praktik komunikasi kesehatan, terdapat berbagai hambatan yang dapat memengaruhi efektivitas mendengarkan.

1. Hambatan internal meliputi kurangnya fokus, emosi negatif, prasangka, serta sikap defensif yang dapat mengganggu penerimaan pesan (Brownell, 2012).
2. Hambatan eksternal seperti kebisingan lingkungan, kondisi tempat yang tidak kondusif, serta gangguan teknologi juga dapat menurunkan kualitas komunikasi.
3. Hambatan lain yang sering terjadi adalah kesalahan interpretasi pesan akibat perbedaan persepsi, latar belakang, atau penggunaan bahasa yang tidak jelas.

Dalam konteks promosi kesehatan, hambatan tersebut dapat mengurangi efektivitas edukasi dan menghambat perubahan perilaku. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu mengidentifikasi dan mengatasi hambatan tersebut agar komunikasi dapat berlangsung secara optimal.

F. Konsep Berpikir Kritis

Berpikir kritis merupakan kemampuan untuk menganalisis informasi secara rasional, sistematis, dan objektif sebelum mengambil keputusan. Dalam promosi kesehatan, kemampuan ini sangat penting karena tenaga kesehatan harus mampu mengevaluasi berbagai informasi kesehatan serta menentukan intervensi yang tepat. Berpikir kritis melibatkan kemampuan analisis, evaluasi, dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Individu yang memiliki kemampuan berpikir kritis cenderung terbuka terhadap berbagai sudut pandang, mampu mengevaluasi informasi, serta tidak mudah menerima informasi tanpa verifikasi (Facione, 2011). Kemampuan ini sangat penting dalam menghadapi kompleksitas masalah kesehatan masyarakat, terutama dalam era informasi digital yang penuh dengan misinformasi..

G. Manfaat dan Pengembangan Berpikir Kritis

Berpikir kritis memberikan manfaat besar dalam promosi kesehatan, terutama dalam pengambilan keputusan yang tepat dan berbasis bukti. Dengan berpikir kritis, individu mampu membedakan antara fakta dan opini serta menghindari kesalahan akibat informasi yang tidak valid (Green & Kreuter, 2005). Berpikir kritis dapat dikembangkan melalui latihan berpikir analitis, diskusi, evaluasi informasi, serta pembiasaan membaca secara kritis. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam

berpikir kritis, seperti bias pribadi, generalisasi berlebihan, serta kesimpulan tanpa data yang cukup. Dalam promosi kesehatan, pengembangan berpikir kritis menjadi bagian penting dalam meningkatkan literasi kesehatan masyarakat.

H. Penerapan dalam Kesehatan Masyarakat

Mendengarkan aktif dan berpikir kritis merupakan dua keterampilan yang saling melengkapi dalam praktik promosi kesehatan. Mendengarkan aktif memungkinkan tenaga kesehatan memahami kondisi, kebutuhan, serta permasalahan masyarakat secara mendalam melalui komunikasi yang efektif. Sementara itu, berpikir kritis digunakan untuk menganalisis informasi yang diperoleh sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan berbasis bukti. Kedua keterampilan ini menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta efektivitas program promosi kesehatan (Notoatmodjo, 2012). Penerapan kedua keterampilan ini dapat dilihat dalam berbagai kegiatan, seperti analisis data kesehatan, identifikasi masalah prioritas, serta evaluasi informasi kesehatan yang beredar di masyarakat (Notoatmodjo, 2012). Selain itu, dalam pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based decision making), tenaga kesehatan perlu mengintegrasikan hasil komunikasi dengan masyarakat dan analisis data secara logis dan objektif. Mendengarkan aktif berperan sebagai sumber data kontekstual yang akurat, sedangkan berpikir kritis berfungsi dalam mengolah data tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat. Oleh karena itu, kedua keterampilan ini menjadi fondasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas program promosi kesehatan.

1. Penerapan dalam Analisis Data Kesehatan

Pada tahap analisis data kesehatan, mendengarkan aktif dan berpikir kritis berperan dalam menghasilkan interpretasi yang akurat dan bermakna. Tenaga kesehatan tidak hanya mengandalkan data kuantitatif, tetapi juga perlu menggali informasi kualitatif dari masyarakat, seperti pengalaman, persepsi, dan keluhan kesehatan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *systems thinking* yang menekankan keterkaitan antara kondisi sosial dan kesehatan masyarakat (Health Promotion International, 2024). Selain itu, kemampuan berpikir kritis diperlukan untuk menginterpretasikan data

secara tepat dan menghindari kesalahan dalam penilaian risiko kesehatan (PLOS ONE, 2024; Heliyon, 2023).

2. **Penerapan dalam Identifikasi Masalah Prioritas**

   Dalam proses identifikasi masalah prioritas, mendengarkan aktif memungkinkan tenaga kesehatan menggali kebutuhan dan permasalahan masyarakat secara langsung. Hal ini penting dalam pendekatan berbasis masyarakat (*community-based approach*). Selanjutnya, berpikir kritis digunakan untuk menganalisis berbagai masalah tersebut dan menentukan prioritas berdasarkan tingkat urgensi, dampak, serta ketersediaan sumber daya. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi berbasis mendengarkan aktif dapat meningkatkan akurasi pemahaman kebutuhan komunitas (Frontiers in Public Health, 2025), sedangkan berpikir kritis berperan penting dalam pengambilan keputusan (Behavioral Sciences, 2024; Scientific Reports, 2024) .

3. **Penerapan dalam Evaluasi Informasi Kesehatan**

   Dalam era digital, tenaga kesehatan dihadapkan pada banyaknya informasi, termasuk misinformasi dan hoaks. Mendengarkan aktif membantu memahami persepsi masyarakat terhadap informasi tersebut, sedangkan berpikir kritis digunakan untuk menilai kredibilitas dan validitas informasi. Literasi kesehatan tidak hanya mencakup kemampuan memahami informasi, tetapi juga mengevaluasinya secara kritis (PLOS ONE, 2024; Behavioral Sciences, 2024) . Dengan demikian, tenaga kesehatan dapat memberikan edukasi yang tepat dan berbasis bukti kepada masyarakat.

4. **Penerapan dalam Pengambilan Keputusan Berbasis Bukti**

   Pengambilan keputusan dalam promosi kesehatan harus berbasis bukti (*evidence-based*). Mendengarkan aktif memungkinkan tenaga kesehatan memahami kebutuhan, nilai, dan preferensi masyarakat, sedangkan berpikir kritis digunakan untuk mengevaluasi bukti ilmiah dan menentukan intervensi yang paling tepat. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi efektif berkontribusi terhadap peningkatan kualitas keputusan kesehatan (BMC Nursing, 2024), sementara pendekatan

berbasis sistem membantu dalam perencanaan intervensi kesehatan (Health Promotion International, 2024) .

5. **Integrasi dalam Praktik Promosi Kesehatan**

   Mendengarkan aktif dan berpikir kritis memiliki hubungan yang erat dalam praktik promosi kesehatan. Mendengarkan aktif berfungsi sebagai dasar dalam memperoleh informasi yang akurat dan kontekstual, sedangkan berpikir kritis memastikan bahwa informasi tersebut dianalisis secara logis dan sistematis. Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan mendengarkan aktif dapat meningkatkan kualitas komunikasi tenaga kesehatan, sedangkan kemampuan berpikir kritis meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan (Frontiers in Public Health, 2025; Behavioral Sciences, 2024) .

Dengan demikian, integrasi kedua keterampilan ini menjadi kunci keberhasilan promosi kesehatan karena mampu meningkatkan pemahaman masyarakat, memperkuat partisipasi, serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan berkelanjutan.

I. Rangkuman

Mendengarkan aktif dan berpikir kritis merupakan dua keterampilan penting yang saling melengkapi dalam komunikasi dan pengambilan keputusan, khususnya dalam kesehatan masyarakat. Mendengarkan aktif memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap informasi dan kondisi masyarakat, sementara berpikir kritis membantu menganalisis dan mengevaluasi informasi tersebut secara logis dan objektif. Dengan mengintegrasikan keduanya, tenaga kesehatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, menentukan solusi yang tepat, serta mengambil keputusan yang efektif dan berbasis bukti..

J. Latihan / Evaluasi

1. Jelaskan perbedaan hearing dan listening!
2. Sebutkan prinsip mendengarkan aktif!
3. Apa saja hambatan dalam mendengarkan?
4. Jelaskan konsep berpikir kritis!
5. Mengapa berpikir kritis penting dalam kesehatan masyarakat?

BAB IV
KOMUNIKASI VERBAL DAN NON VERBAL

A. Konsep Komunikasi Kesehatan

Komunikasi kesehatan merupakan proses penyampaian informasi terkait kesehatan kepada individu, kelompok, maupun masyarakat dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan. Dalam konteks promosi kesehatan, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai proses interaksi yang bertujuan memengaruhi pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat. World Health Organization menyatakan bahwa komunikasi kesehatan berperan penting dalam mendukung perubahan perilaku melalui penyampaian pesan yang jelas, akurat, dan mudah dipahami (WHO, 2021). Selain itu, komunikasi kesehatan yang efektif terbukti dapat meningkatkan literasi kesehatan serta membantu individu dalam mengambil keputusan yang tepat terkait kesehatannya (Health Communication Journal, 2022). Oleh karena itu, komunikasi kesehatan menjadi komponen utama dalam promosi kesehatan karena berfungsi sebagai penghubung antara ilmu kesehatan dan praktik kehidupan sehari-hari (Schiavo, 2014)

Unsur-unsur Komunikasi Kesehatan terdiri atas beberapa unsur utama yang saling berkaitan, yaitu:

1. **Komunikator**

   Komunikator adalah pihak yang menyampaikan pesan, seperti tenaga kesehatan, penyuluh, atau edukator. Peran komunikator sangat menentukan keberhasilan komunikasi karena berkaitan dengan kredibilitas dan kemampuan menyampaikan pesan.

2. **Pesan**

   Pesan merupakan informasi kesehatan yang disampaikan kepada sasaran. Pesan harus disusun secara jelas, sederhana, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. **Media atau Saluran**

   Media digunakan sebagai sarana penyampaian pesan, baik melalui

komunikasi langsung maupun media massa dan digital.

4. **Komunikan**

Komunikan adalah penerima pesan, yaitu individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran edukasi.

5. **Efek**

Efek merupakan hasil yang diharapkan, seperti perubahan pengetahuan, sikap, atau perilaku kesehatan.

Proses komunikasi kesehatan bersifat dua arah, melibatkan penyampaian pesan, penerimaan, interpretasi, serta respons dari komunikan. Efektivitas komunikasi sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara pesan, media, dan karakteristik sasaran (Journal of Health Communication, 2023) . Selain itu, komunikasi yang melibatkan umpan balik (*feedback*) terbukti dapat meningkatkan pemahaman dan keberhasilan intervensi kesehatan (BMC Public Health, 2022)

B. Komunikasi Verbal

1. **Pengertian**

Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan, untuk menyampaikan pesan. Dalam pelayanan kesehatan, komunikasi verbal digunakan dalam kegiatan konsultasi, penyuluhan, konseling, dan edukasi kesehatan. Komunikasi verbal yang efektif ditandai dengan penggunaan bahasa yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami oleh sasaran. Penggunaan bahasa yang sederhana sesuai tingkat pendidikan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap pengobatan (Patient Education and Counseling, 2021) .

2. **Kelebihan dan Keterbatasan**

1) **Kelebihan**

Komunikasi verbal mampu menyampaikan informasi secara rinci dan sistematis serta memungkinkan adanya klarifikasi langsung antara komunikator dan komunikan.

2) **Keterbatasan**

Komunikasi verbal berpotensi menimbulkan kesalahpahaman apabila

pesan tidak disampaikan dengan jelas atau terdapat perbedaan bahasa dan budaya.

Dengan demikian, tenaga kesehatan perlu memiliki keterampilan komunikasi verbal yang baik agar pesan kesehatan dapat diterima secara optimal.

3. Penerapan dalam Promosi Kesehatan

Dalam praktik promosi kesehatan, komunikasi verbal digunakan dalam berbagai kegiatan seperti penyuluhan, konseling, edukasi pasien, dan kampanye kesehatan. Di Indonesia, komunikasi verbal banyak diterapkan dalam kegiatan puskesmas, posyandu, serta program berbasis masyarakat.

Penggunaan bahasa yang sederhana dan sesuai konteks budaya sangat penting dalam meningkatkan efektivitas komunikasi. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi verbal yang baik dapat meningkatkan literasi kesehatan dan membantu masyarakat dalam mengambil keputusan kesehatan yang tepat (Journal of Health Communication, 2022) . Selain itu, penggunaan bahasa lokal terbukti lebih efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat (Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia, 2022).

C. Komunikasi Nonverbal

1. Pengertian

Komunikasi nonverbal merupakan proses penyampaian pesan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan melalui ekspresi wajah, bahasa tubuh, kontak mata, dan isyarat lainnya. Dalam konteks kesehatan, komunikasi nonverbal berperan penting dalam memperkuat pesan verbal serta membangun hubungan interpersonal. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi nonverbal berkontribusi besar dalam membangun hubungan terapeutik antara tenaga kesehatan dan pasien (Journal of Nonverbal Behavior, 2022) .

2. Kelebihan dan Keterbatasan

1) Kelebihan

Komunikasi nonverbal efektif dalam menyampaikan emosi,

empati, dan kedekatan.

2) **Keterbatasan**

Makna komunikasi nonverbal dapat berbeda tergantung konteks budaya sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.

3) Penerapan dalam Promosi Kesehatan

Dalam praktik promosi kesehatan, komunikasi nonverbal digunakan untuk menunjukkan empati, perhatian, dan dukungan kepada masyarakat. Kontak mata, ekspresi ramah, dan sikap terbuka dapat meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan masyarakat dalam program kesehatan (Frontiers in Public Health, 2024)

D. Jenis Komunikasi Nonverbal

1. Kinesik (Gerakan Tubuh dan Ekspresi Wajah)

Kinesik merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang berkaitan dengan gerakan tubuh, seperti gestur tangan, postur tubuh, serta ekspresi wajah. Dalam interaksi, kinesik memiliki peran penting dalam menyampaikan emosi, sikap, dan respons seseorang terhadap pesan yang diterima. Ekspresi wajah, seperti senyum, dahi berkerut, atau tatapan serius, dapat memberikan makna tambahan terhadap pesan verbal yang disampaikan. Dalam konteks pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan yang menunjukkan ekspresi ramah dan terbuka akan lebih mudah membangun kepercayaan dengan pasien. Sebaliknya, ekspresi yang kaku atau tidak peduli dapat menimbulkan kesan negatif.

Gambar 3. 1 Ilustrasi Jenis Komunikasi Nonverbal Kinesik

2. Okulasik (Kontak Mata)

Okulasik adalah komunikasi nonverbal yang berkaitan dengan penggunaan kontak mata dalam interaksi. Kontak mata dapat menunjukkan

perhatian, ketertarikan, kejujuran, dan keterlibatan dalam komunikasi. Dalam pelayanan kesehatan, kontak mata yang tepat dapat membantu membangun hubungan yang lebih dekat antara tenaga kesehatan dan pasien. Kontak mata yang terlalu sedikit dapat diartikan sebagai kurangnya perhatian, sedangkan kontak mata yang berlebihan dapat menimbulkan rasa tidak nyaman

Gambar 3. 2 Ilustrasi Jenis Komunikasi Nonverbal Okulasik

3. **Haptik (Sentuhan)**

Haptik merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang melibatkan sentuhan fisik sebagai sarana penyampaian pesan. Sentuhan dapat digunakan untuk menunjukkan empati, dukungan, dan perhatian, misalnya dengan menepuk bahu atau menggenggam tangan pasien. Dalam konteks kesehatan, sentuhan sering digunakan untuk memberikan rasa nyaman dan menenangkan pasien. Namun, penggunaan sentuhan harus dilakukan secara hati-hati karena dapat dipengaruhi oleh norma budaya, usia, jenis kelamin, dan kondisi individu. Jika tidak tepat, sentuhan dapat menimbulkan ketidaknyamanan atau kesalahpahaman.

Gambar 3. 3 Ilustrasi Jenis Komunikasi Nonverbal Haptik

4. **Proksemik (Jarak)**

Proksemik berkaitan dengan penggunaan jarak fisik dalam komunikasi. Jarak antara individu dapat mencerminkan tingkat keakraban, hubungan sosial, serta rasa nyaman dalam interaksi. Dalam pelayanan kesehatan, pengaturan jarak sangat penting agar pasien merasa nyaman dan tidak terintimidasi. Jarak yang terlalu dekat dapat membuat pasien merasa tidak nyaman, sedangkan jarak yang terlalu jauh dapat mengurangi kedekatan dan kehangatan komunikasi.

Gambar 3. 4 Ilustrasi Jenis Komunikasi Nonverbal Proksemik

5. **Paralanguage (Intonasi Suara)**

Paralanguage merujuk pada aspek suara dalam komunikasi, seperti intonasi, volume, kecepatan bicara, dan penekanan kata. Meskipun bukan bagian dari kata-kata itu sendiri, paralanguage sangat memengaruhi makna pesan yang disampaikan. Dalam komunikasi kesehatan, intonasi suara yang lembut dan jelas dapat membantu pasien merasa lebih tenang dan memahami informasi dengan lebih baik. Sebaliknya, suara yang terlalu keras, cepat, atau monoton dapat menyebabkan kesalahpahaman atau menimbulkan kecemasan.

6. **Penampilan Fisik**

Penampilan fisik merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang mencakup cara berpakaian, kebersihan diri, dan penampilan umum seseorang. Dalam konteks kesehatan, penampilan tenaga kesehatan yang rapi, bersih, dan profesional dapat meningkatkan kepercayaan pasien. Penampilan juga dapat mencerminkan sikap dan profesionalisme seseorang dalam bekerja.

7. **Olfaktik (Bau)**

Olfaktik berkaitan dengan komunikasi nonverbal melalui indera penciuman, yaitu bau atau aroma yang tercium dalam suatu interaksi. Bau dapat

memengaruhi persepsi seseorang terhadap lingkungan atau individu tertentu. Dalam pelayanan kesehatan, menjaga kebersihan dan menghindari bau yang tidak sedap sangat penting untuk menciptakan kenyamanan pasien. Sebaliknya, bau yang tidak menyenangkan dapat mengganggu komunikasi dan menurunkan kualitas interaksi.

8. **Kronemik (Waktu)**

   Kronemik adalah penggunaan waktu dalam komunikasi, seperti ketepatan waktu, durasi interaksi, dan kecepatan respons. Dalam pelayanan kesehatan, ketepatan waktu menunjukkan profesionalisme dan menghargai pasien. Waktu yang cukup dalam komunikasi juga penting agar pasien dapat memahami informasi yang diberikan dengan baik. Sebaliknya, komunikasi yang terburu-buru dapat membuat pasien merasa tidak diperhatikan.

9. **Faktor Lingkungan**

   Faktor lingkungan mencakup kondisi fisik tempat komunikasi berlangsung, seperti pencahayaan, kebisingan, suhu ruangan, dan tata ruang. Lingkungan yang nyaman dan kondusif dapat mendukung komunikasi yang efektif, sedangkan lingkungan yang bising atau tidak nyaman dapat mengganggu proses komunikasi. Dalam pelayanan kesehatan, ruang yang bersih, tenang, dan tertata dengan baik dapat meningkatkan kenyamanan pasien serta membantu mereka lebih fokus dalam menerima informasi.

E. Hubungan Komunikasi Verbal dan Nonverbal

Komunikasi verbal dan nonverbal memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi dalam proses komunikasi kesehatan. Komunikasi nonverbal dapat memperkuat pesan verbal dengan memberikan penekanan emosional dan konteks tambahan, sehingga pesan menjadi lebih mudah dipahami. Selain itu, komunikasi nonverbal juga dapat menggantikan pesan verbal dalam situasi tertentu, misalnya ketika kata-kata tidak cukup untuk menyampaikan empati. Menurut penelitian dalam *Health Communication Research* (2022), keselarasan antara komunikasi verbal dan nonverbal sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pasien. Komunikasi nonverbal juga berperan dalam mengatur jalannya komunikasi, seperti melalui kontak mata atau gerakan tubuh yang menunjukkan giliran berbicara. Ketidaksesuaian antara komunikasi verbal dan nonverbal dapat menyebabkan

kebingungan atau ketidakpercayaan pada penerima pesan. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu mampu mengintegrasikan kedua bentuk komunikasi ini secara efektif untuk mencapai tujuan komunikasi kesehatan yang optimal.

F. Rangkuman

Komunikasi kesehatan bertujuan menyampaikan pesan agar masyarakat memahami dan melakukan perilaku sehat. Komunikasi verbal menyampaikan informasi, sedangkan komunikasi nonverbal memperkuat makna dan emosi, sehingga keduanya harus digunakan secara bersamaan agar komunikasi lebih efektif.

G. Latihan / Evaluasi

1. Jelaskan pengertian komunikasi kesehatan!
2. Sebutkan unsur-unsur komunikasi kesehatan!
3. Apa perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal?
4. Sebutkan jenis komunikasi nonverbal!
5. Mengapa komunikasi nonverbal penting dalam promosi kesehatan?

BAB V
TEORI TENTANG KONSELING

A. Konsep Konseling

Konseling merupakan proses bantuan profesional yang dilakukan melalui hubungan interpersonal antara konselor dan klien untuk membantu klien memahami dirinya, mengenali masalah, serta menentukan solusi yang tepat. Konseling bukan sekadar pemberian nasihat, melainkan proses yang terencana, sistematis, dan berorientasi pada kebutuhan klien. Dalam proses ini, konselor menciptakan suasana yang aman dan suportif agar klien dapat mengekspresikan pikiran, perasaan, serta pengalaman hidupnya secara terbuka. Hubungan konseling harus didasarkan pada kepercayaan, penerimaan, dan penghargaan terhadap klien sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk berkembang (Corey, 2017).

B. Tujuan Konseling dalam Promosi Kesehatan

Dalam konteks promosi kesehatan, konseling bertujuan membantu individu memahami masalah kesehatan, mengenali faktor risiko, serta mendorong perubahan perilaku menuju pola hidup sehat. Banyak masalah kesehatan tidak hanya dipengaruhi faktor biologis, tetapi juga faktor psikologis, sosial, dan budaya (Notoatmodjo, 2012) . Selain itu, konseling berperan dalam meningkatkan kemampuan klien untuk:

1. mengambil keputusan secara mandiri,
2. memecahkan masalah kesehatan,
3. serta bertanggung jawab terhadap kesehatannya.

Melalui pendekatan ini, konseling tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga memberdayakan individu agar mampu menghadapi masalah kesehatan di masa depan (Egan, 2014)

C. Konseling dalam Perubahan Perilaku

Dalam promosi kesehatan, konseling berperan penting dalam mengubah perilaku berisiko menjadi perilaku sehat, seperti merokok, pola makan tidak sehat, dan kurang aktivitas fisik. Melalui komunikasi dua arah yang empatik, konseling membantu klien:

1. mengenali risiko kesehatan,
2. meningkatkan kesadaran,
3. memperkuat motivasi,
4. serta membangun komitmen untuk berubah.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep *motivational interviewing* yang menekankan pentingnya motivasi internal dalam perubahan perilaku (Miller & Rollnick, 2013)

D. Prinsip Konseling

1. **Hubungan Kolaboratif**

   Konseling merupakan hubungan kemitraan antara konselor dan klien. Konselor berperan sebagai fasilitator yang membantu klien memahami masalah dan menemukan solusi.

2. **Kemandirian Klien**

   Konselor tidak memberikan keputusan secara sepihak, tetapi membantu klien menemukan solusi sendiri yang sesuai dengan kondisinya.

3. **Orientasi pada Tujuan**

   Konseling memiliki tujuan yang disepakati bersama agar proses lebih terarah, terukur, dan bermakna.

Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa konseling berfokus pada pemberdayaan klien, bukan ketergantungan (Corey, 2017; Egan, 2014)

E. Ruang Lingkup Konseling

1. Berdasarkan Bentuk Pelaksanaan

1) Konseling Individu

Konseling dilakukan secara tatap muka antara konselor dan klien sehingga memungkinkan pembahasan masalah secara mendalam dan bersifat rahasia.

2) Konseling Kelompok

Konseling dilakukan dalam kelompok dengan masalah yang serupa. Pendekatan ini memungkinkan adanya dukungan sosial dan pembelajaran bersama.

Kedua bentuk ini digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sasaran (Egan, 2014; Corey, 2016) .

2. **Berdasarkan Tujuan**

   1) Konseling Promotif

   Bertujuan meningkatkan kesadaran dan perilaku sehat, seperti konseling gizi dan aktivitas fisik.

   2) Konseling Preventif

   Bertujuan mencegah timbulnya penyakit, seperti konseling berhenti merokok atau pencegahan HIV.

   3) Konseling Rehabilitatif

   Bertujuan membantu pemulihan dan penyesuaian kondisi kesehatan, seperti konseling pasien penyakit kronis.

   Pembagian ini menunjukkan bahwa konseling merupakan bagian penting dalam promosi kesehatan (Notoatmodjo, 2012) .

3. **Berdasarkan Masalah Kesehatan**

   Konseling dapat diterapkan pada berbagai masalah kesehatan, seperti:

   1) gizi dan stunting,
   2) penyakit menular dan tidak menular,
   3) kesehatan reproduksi,
   4) kesehatan jiwa,
   5) serta perilaku berisiko.

   Hal ini menunjukkan bahwa konseling merupakan bagian integral dari intervensi kesehatan masyarakat (Green & Kreuter, 2005)

F. Teori-Teori Konseling

1. **Teori Psikoanalitik**

   Teori ini menekankan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh konflik bawah sadar dan pengalaman masa lalu (Corey, 2017) .

2. **Teori Behavioristik**

   Pendekatan ini berfokus pada perubahan perilaku melalui penguatan dan pembelajaran (Skinner, 1953) .

3. **Teori Kognitif**

   Pendekatan ini menekankan bahwa pola pikir memengaruhi emosi dan

perilaku (Ellis, 2003) .

4. **Teori Humanistik**

   Pendekatan ini berfokus pada potensi individu dan hubungan empatik dalam konseling (Rogers, 1983) .

5. **Pendekatan Integratif**

   Pendekatan ini menggabungkan berbagai teori untuk menyesuaikan dengan kebutuhan klien (Corey, 2017)

G. Tokoh-Tokoh Konseling

Tokoh utama dalam perkembangan konseling meliputi:

1. Sigmund Freud (psikoanalitik)

   Sigmund Freud mengembangkan psikoanalisis yang menekankan peran bawah sadar, pengalaman masa kecil, serta konflik id, ego, dan superego dalam perilaku manusia.

2. B.F. Skinner (behavioristik)

   B.F. Skinner melalui behaviorisme menjelaskan bahwa perilaku dapat dibentuk dan diubah lewat konsekuensi (*operant conditioning).*

3. Albert Ellis (kognitif/REBT)

   Albert Ellis mengembangkan *Rational Emotive Behavior Therapy* (REBT), yang menekankan bahwa emosi dipengaruhi oleh pikiran irasional yang perlu diubah menjadi rasional.

4. Carl Rogers (humanistik)

   Carl Rogers dengan pendekatan humanistik (*client-centered*) menekankan empati, penerimaan tanpa syarat, dan keaslian dalam membantu klien berkembang.

Keempat tokoh ini memberikan kontribusi besar dalam pengembangan teori dan praktik konseling modern (Corey, 2017)

H. Penerapan Konseling dalam Promosi Kesehatan

1. Perubahan Perilaku Berisiko

   Konseling digunakan untuk membantu individu mengubah perilaku berisiko, seperti merokok. Penelitian menunjukkan bahwa konseling efektif dalam meningkatkan motivasi dan keberhasilan berhenti merokok (Reskiaddin

& Supriyati, 2021) .

2. Pendekatan Berbasis Komunitas

   Konseling dalam program seperti GERMAS mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui pendekatan yang sesuai dengan konteks sosial budaya (Hiola et al., 2021) .

3. Konseling pada Remaja

   Konseling kesehatan pada remaja terbukti meningkatkan perubahan perilaku melalui intervensi yang berkelanjutan (MKMI, 2021).

4. Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan

   Pelatihan konseling meningkatkan keterampilan komunikasi dan kepercayaan diri tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi (Trisnowati & Suryana, 2024) .

5. Peran Konseling dalam Promosi Kesehatan

Secara keseluruhan, konseling merupakan strategi efektif dalam promosi kesehatan karena mampu meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap, serta mendorong perubahan perilaku secara berkelanjutan (Reskiaddin & Supriyati, 2021; Hiola et al., 2021) .

I. Rangkuman

Konseling merupakan proses bantuan profesional yang bertujuan membantu individu memahami diri, mengatasi masalah, serta mengambil keputusan yang tepat, khususnya dalam konteks kesehatan. Dengan didukung berbagai teori dan pendekatan, konseling dapat diterapkan dalam berbagai aspek kesehatan. Secara keseluruhan, konseling terbukti menjadi strategi yang efektif dalam promosi kesehatan karena mampu meningkatkan pengetahuan, kesadaran, serta mendorong perubahan perilaku yang lebih sehat dan berkelanjutan.

J. Latihan / Evaluasi

1. Jelaskan pengertian konseling kesehatan!
2. Apa tujuan konseling dalam promosi kesehatan?
3. Sebutkan teori-teori konseling!
4. Jelaskan perbedaan pendekatan behavioristik dan humanistik!
5. Mengapa komunikasi empatik penting dalam konseling?

BAB VI
ETIKA KONSELING

A. Pengertian dan Pentingnya Etika Konseling

Etika konseling merupakan seperangkat prinsip moral, nilai, dan standar profesional yang menjadi pedoman bagi konselor dalam menjalankan praktik secara bertanggung jawab, aman, dan profesional. Etika tidak hanya mengatur perilaku dalam situasi ideal, tetapi juga memberikan arahan dalam menghadapi dilema etika dalam praktik nyata.

Dalam konteks ini, etika berfungsi sebagai kerangka kerja untuk membedakan tindakan yang benar dan salah, serta memastikan bahwa setiap keputusan berorientasi pada kepentingan terbaik klien (Corey, 2017) . Dengan demikian, etika menjadi dasar dalam menjaga kualitas dan standar praktik konseling.

B. Fungsi Etika sebagai Perlindungan Klien

Etika konseling berfungsi sebagai perlindungan bagi klien yang sering berada dalam kondisi rentan, baik secara emosional, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, etika diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh konselor, seperti manipulasi, eksploitasi, atau pelanggaran kerahasiaan.

Kode etik memastikan bahwa hak klien tetap dihormati, termasuk hak atas privasi, keamanan, dan perlakuan yang adil (ACA, 2014) . Tanpa etika, hubungan konseling berisiko menjadi tidak seimbang dan merugikan klien.

C. Peran Etika dalam Hubungan Terapeutik

Etika memiliki peran penting dalam membangun hubungan terapeutik yang aman dan penuh kepercayaan antara konselor dan klien. Keberhasilan konseling sangat dipengaruhi oleh tingkat kenyamanan dan kepercayaan klien dalam proses tersebut. Konselor yang menjunjung tinggi etika akan menciptakan suasana yang aman sehingga klien dapat terbuka dalam mengungkapkan masalahnya. Sebaliknya, pelanggaran etika dapat merusak kepercayaan dan menghambat proses konseling (Welfel, 2016) . Oleh karena itu, etika merupakan fondasi utama dalam praktik konseling yang efektif.

D. Prinsip-Prinsip Etika Konseling

1. *Autonomy* (Otonomi)

   Prinsip ini menekankan penghormatan terhadap hak klien untuk mengambil keputusan sendiri. Konselor tidak boleh memaksakan nilai atau keputusan kepada klien (Beauchamp & Childress, 2013) .

2. *Beneficence* (Kebajikan)

   Konselor berkewajiban bertindak untuk memberikan manfaat terbaik bagi klien, termasuk menggunakan pendekatan yang sesuai dan berbasis bukti.

3. *Non-maleficence* (Tidak Merugikan)

   Konselor harus menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kerugian fisik maupun psikologis bagi klien (Corey, 2017) .

4. *Justice* (Keadilan)

   Konselor wajib memberikan layanan secara adil tanpa diskriminasi terhadap latar belakang klien.

5. *Fidelity* (Kesetiaan/Kepercayaan)

   Konselor harus menjaga kepercayaan, komitmen, dan tanggung jawab profesional, termasuk menjaga kerahasiaan klien (Welfel, 2016) .

Kelima prinsip ini menjadi dasar dalam praktik konseling yang etis dan profesional.

E. Kode Etik Konselor

1. Pengertian Kode Etik

Kode etik konselor merupakan seperangkat aturan formal yang disusun oleh organisasi profesi untuk mengatur perilaku profesional konselor. Kode etik berfungsi sebagai pedoman dalam praktik serta sebagai acuan dalam pengambilan keputusan etis (ACA, 2014) .

2. Fungsi Kode Etik

1) Sebagai standar praktik profesional
2) Sebagai pedoman dalam menghadapi dilema etika
3) Sebagai alat evaluasi terhadap pelanggaran

Dengan adanya kode etik, konselor memiliki batasan yang jelas dalam menjalankan praktik profesional.

3. Isi Kode Etik

Kode etik mencakup berbagai aspek, antara lain:

1) kompetensi konselor,
2) kerahasiaan klien,
3) batasan hubungan profesional,
4) serta penanganan konflik kepentingan.

Konselor wajib bekerja sesuai kompetensi serta terus meningkatkan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan (Corey, 2017)

F. Hak dan Kewajiban dalam Konseling

1. Hak dan Kewajiban Konselor

Konselor memiliki kewajiban memberikan layanan profesional, menjaga kerahasiaan, serta menghormati hak klien. Selain itu, konselor harus bekerja sesuai standar dan tidak melampaui kompetensinya. Di sisi lain, konselor memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jujur dari klien serta bekerja dalam lingkungan yang mendukung praktik profesional (Welfel, 2016) .

2. Hak dan Kewajiban Klien

Klien memiliki hak untuk:

1) mendapatkan layanan yang aman dan tidak diskriminatif,
2) mengetahui proses dan tujuan konseling,
3) serta menentukan keputusan terkait dirinya sendiri.

Klien juga memiliki kewajiban untuk berpartisipasi aktif dan jujur dalam proses konseling.

3. Informed Consent

Informed consent adalah persetujuan yang diberikan klien setelah menerima informasi lengkap mengenai proses konseling. Hal ini penting untuk memastikan bahwa klien memahami tujuan, manfaat, serta risiko konseling dan memberikan persetujuan secara sukarela (Corey, 2017)

G. Pelanggaran Etika dan Tanggung Jawab Profesional

1. Bentuk Pelanggaran Etika

1) membuka rahasia klien tanpa izin,
2) hubungan ganda yang tidak profesional,
3) serta manipulasi terhadap klien.

Pelanggaran ini dapat berdampak serius terhadap kondisi psikologis dan sosial klien (ACA, 2014) .

2. Konsekuensi Pelanggaran Etika

Pelanggaran etika dapat menyebabkan:

1) sanksi profesional,
2) konsekuensi hukum,
3) serta kerusakan reputasi konselor.

Kepercayaan merupakan aspek utama dalam konseling yang sulit dipulihkan jika telah rusak (Welfel, 2016) .

3. Tanggung Jawab Profesional Konselor

Sebagai bentuk tanggung jawab profesional, konselor harus:

1) melakukan refleksi diri,
2) mengikuti supervisi,
3) serta meningkatkan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan.

Hal ini penting untuk menjaga kualitas layanan dan profesionalisme (Corey, 2017)

H. Sensitivitas Budaya dalam Konseling

1. Pengertian Sensitivitas Budaya

Sensitivitas budaya adalah kemampuan konselor memahami dan menghargai latar belakang budaya klien, termasuk nilai, norma, dan kepercayaan. Pendekatan konseling harus disesuaikan dengan konteks budaya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau penolakan (Sue & Sue, 2016) .

2. Prinsip Sensitivitas Budaya

Konselor harus:

1) menghindari stereotip dan diskriminasi,
2) menggunakan pendekatan non-judgmental,
3) serta memahami perspektif klien.

Hal ini penting untuk menciptakan suasana yang aman dan mendukung.

3. Penerapan dalam Praktik Konseling

Dalam praktik, konselor perlu menyesuaikan teknik dan strategi konseling sesuai budaya klien. Tidak semua pendekatan cocok untuk semua kelompok, sehingga fleksibilitas sangat diperlukan. Dengan demikian, sensitivitas budaya menjadi bagian penting dalam praktik konseling yang etis, efektif, dan relevan

dalam konteks promosi kesehatan.

I. Rangkuman

Etika konseling adalah pedoman moral dan profesional yang mengatur praktik konseling agar aman, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan klien, dengan prinsip utama seperti menghargai keputusan klien, tidak merugikan, memberikan manfaat, menjaga kepercayaan, dan keadilan, serta didukung kode etik, informed consent, tanggung jawab profesional, dan sensitivitas budaya.

J. Latihan / Evaluasi

1. Jelaskan pengertian etika dalam konseling!
2. Sebutkan prinsip-prinsip etika konseling!
3. Apa fungsi kode etik konselor?
4. Jelaskan hak dan kewajiban klien dalam konseling!
5. Mengapa sensitivitas budaya penting dalam konseling kesehatan?

BAB VII
KONSEP MOTIVATIONAL INTERVIEWING (MI)

A. Latar Belakang *Motivational Interviewing*

Permasalahan kesehatan masyarakat tidak hanya disebabkan oleh faktor biologis, tetapi sangat dipengaruhi oleh perilaku individu. Perilaku seperti merokok, pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, ketidakpatuhan pengobatan, serta perilaku seksual berisiko merupakan faktor utama penyebab berbagai penyakit. Meskipun edukasi kesehatan telah dilakukan secara luas, perubahan perilaku sering kali sulit dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan saja tidak cukup untuk mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan.

Pendekatan edukasi tradisional yang bersifat satu arah, seperti ceramah atau nasihat, cenderung kurang efektif karena tidak mempertimbangkan kondisi psikologis individu. Banyak individu sudah memahami risiko perilakunya, tetapi tetap tidak melakukan perubahan karena adanya ambivalensi, yaitu kondisi konflik antara keinginan berubah dan mempertahankan kebiasaan lama. Selain itu, resistensi juga muncul ketika individu merasa dipaksa atau dihakimi (Miller & Rollnick, 2013).

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih humanistik dan berpusat pada klien. *Motivational Interviewing* (MI) merupakan pendekatan yang menekankan eksplorasi motivasi internal individu untuk berubah. Pendekatan ini relevan dalam promosi kesehatan karena mampu mendorong perubahan perilaku secara sukarela dan berkelanjutan.

B. Definisi *Motivational Interviewing*

1. Definisi M*otivational Interviewing*

Motivational Interviewing (MI) adalah pendekatan komunikasi kolaboratif yang bertujuan memperkuat motivasi internal individu dalam melakukan perubahan perilaku. MI tidak bersifat memaksa, melainkan membantu klien menemukan alasan perubahan dari dalam dirinya sendiri. Dalam pendekatan ini, konselor berperan sebagai fasilitator yang mendukung proses eksplorasi, bukan sebagai pihak yang mendikte keputusan klien (Miller & Rollnick, 2013) .

2. Komponen *Motivational Interviewing*

1) *Partnership* (Kemitraan)

Hubungan antara konselor dan klien bersifat setara dan kolaboratif.

2) *Acceptance* (Penerimaan)

Konselor menerima klien tanpa menghakimi serta menghargai nilai dan pilihan klien.

3) *Compassion* (Kepedulian)

Konselor menunjukkan kepedulian tulus terhadap kesejahteraan klien.

4) *Evocation* (Penggalian)

Motivasi perubahan digali dari dalam diri klien, bukan diberikan dari luar.

Keempat komponen ini menciptakan suasana komunikasi yang aman dan mendukung, sehingga klien lebih terbuka dalam proses perubahan (Miller & Rollnick, 2013) .

C. Prinsip Dasar Motivational Interviewing

1. ***Express Empathy***

Konselor menunjukkan empati melalui sikap non-judgmental dan mendengarkan aktif. Hal ini membuat klien merasa dihargai dan lebih terbuka.

2. ***Develop Discrepancy***

Konselor membantu klien menyadari kesenjangan antara perilaku saat ini dan tujuan yang diinginkan. Kesadaran ini mendorong motivasi perubahan.

3. ***Roll with Resistance***

Resistensi tidak dilawan, tetapi dipahami sebagai bagian dari proses perubahan. Konselor bersikap fleksibel dan tidak konfrontatif.

4. ***Support Self-Efficacy***

Konselor mendukung keyakinan klien bahwa mereka mampu melakukan perubahan.

Keempat prinsip ini menjadi dasar dalam menciptakan proses konseling yang efektif dan berorientasi perubahan perilaku (Miller & Rollnick, 2013)

D. Teknik OARS

1. ***Open-ended Questions***

Pertanyaan terbuka digunakan untuk menggali informasi secara mendalam dan mendorong klien berbicara lebih luas.

2. ***Affirmation***

Afirmasi diberikan untuk memperkuat kepercayaan diri dan motivasi klien.

3. ***Reflective Listening***

Konselor memparafrasekan pernyataan klien untuk menunjukkan pemahaman dan memperdalam refleksi.

4. ***Summarizing***

Konselor merangkum pembicaraan untuk memperjelas arah diskusi.

Penggunaan teknik OARS meningkatkan kualitas komunikasi serta memperkuat hubungan terapeutik dalam konseling (Miller & Rollnick, 2013)

E. Change Talk dan Sustain Talk

1. Change Talk

Change talk adalah pernyataan klien yang menunjukkan keinginan, alasan, atau komitmen untuk berubah, seperti "Saya ingin hidup lebih sehat". Pernyataan ini menjadi indikator penting dalam proses perubahan perilaku.

2. **Sustain Talk**

Sustain talk adalah pernyataan yang menunjukkan keinginan mempertahankan perilaku lama, seperti "Saya sudah terbiasa merokok".

Dalam MI, sustain talk tidak ditolak, tetapi dieksplorasi untuk memahami ambivalensi klien. Fokus utama konselor adalah memperkuat change talk agar motivasi perubahan meningkat (Miller & Rollnick, 2013)

F. Model DARN-CAT

1. **Komponen DARN**

1) ***Desire*** → keinginan untuk berubah
2) ***Ability*** → keyakinan mampu berubah
3) ***Reasons*** → alasan untuk berubah
4) ***Need*** → kebutuhan untuk berubah

2. **Komponen CAT**

1) ***Commitment*** → komitmen untuk berubah
2) ***Activation*** → kesiapan bertindak
3) ***Taking Steps*** → tindakan nyata

Model ini membantu konselor menilai kesiapan perubahan klien dan menyesuaikan strategi konseling (Miller & Rollnick, 2013).

G. Tahapan Proses Motivational Interviewing

1. Engaging

Tahap ini bertujuan membangun hubungan yang aman dan penuh kepercayaan antara konselor dan klien. Konselor menggunakan komunikasi empatik agar klien merasa nyaman dan terbuka.

2. Focusing

Tahap ini menentukan arah perubahan dengan mengidentifikasi masalah utama yang ingin diatasi. Konselor dan klien menetapkan fokus secara bersama.

3. Evoking

Tahap ini bertujuan menggali motivasi internal klien melalui eksplorasi change talk. Konselor membantu klien menyadari alasan dan manfaat perubahan.

3. Planning

Tahap ini menyusun rencana tindakan yang konkret dan realistis. Konselor membantu klien menentukan langkah perubahan serta mengantisipasi hambatan.

Keempat tahap ini membentuk proses perubahan perilaku yang sistematis dan berkelanjutan dalam promosi kesehatan (Miller & Rollnick, 2013)

H. Rangkuman

Motivational Interviewing merupakan pendekatan komunikasi yang berfokus pada klien untuk menggali motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku kesehatan. Dengan prinsip empati, teknik OARS, serta tahapan proses yang sistematis, *Motivational Interviewing* efektif dalam mengatasi resistensi dan meningkatkan komitmen perubahan.

I. Latihan / Evaluasi

1. Jelaskan konsep Motivational Interviewing!
2. Apa yang dimaksud dengan spirit *Motivational Interviewing*?
3. Sebutkan teknik OARS!
4. Jelaskan perbedaan change talk dan sustain talk!
5. Sebutkan tahapan proses *Motivational Interviewing*!

BAB VIII
TEKNIK REFLEKSI DAN PARAFRASE

A. Konsep Refleksi dan Parafrase

Refleksi dan parafrase merupakan keterampilan inti dalam konseling yang termasuk dalam kategori *responding skills*, yaitu kemampuan konselor dalam memberikan tanggapan secara tepat, empatik, dan bermakna terhadap pernyataan klien. Keterampilan ini tidak hanya merupakan teknik komunikasi, tetapi juga menjadi komponen penting dalam membangun hubungan terapeutik yang efektif.

Refleksi berfokus pada kemampuan konselor dalam menangkap serta mengungkapkan kembali perasaan, makna, dan pengalaman emosional klien. Sementara itu, parafrase berfokus pada penyampaian ulang isi pembicaraan klien dengan bahasa yang lebih ringkas dan jelas tanpa mengubah makna (Egan, 2019) .

Dalam praktik konseling, kedua teknik ini saling melengkapi. Refleksi membantu klien menyadari emosi yang mungkin belum sepenuhnya dipahami, sedangkan parafrase membantu menyusun informasi agar lebih sistematis. Penggunaan keduanya secara tepat dapat meningkatkan kualitas komunikasi sehingga klien merasa didengar, dipahami, dan dihargai. Hal ini menunjukkan bahwa refleksi dan parafrase tidak hanya berfungsi sebagai teknik komunikasi, tetapi juga sebagai sarana penting dalam mendukung perubahan psikologis dan perilaku klien (Corey, 2017)

B. Landasan Teoretis

1. Teori The Skilled Helper

Penggunaan refleksi dan parafrase memiliki dasar teoretis yang kuat, salah satunya berasal dari konsep *The Skilled Helper* yang dikembangkan oleh Egan (2019). Teori ini menekankan tiga komponen utama:

1) **Empathic Presence**

   Konselor hadir secara utuh, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis dalam proses konseling.

2) **Active Listening**

   Konselor mampu mendengarkan secara aktif, termasuk memahami pesan verbal dan nonverbal klien.

3) **Accurate Responding**

Konselor memberikan respons yang sesuai dengan isi dan perasaan yang disampaikan klien.

Ketiga komponen ini menjadi dasar dalam membangun komunikasi yang efektif dan bermakna dalam konseling .

2. Pendekatan Humanistik (Carl Rogers)

Selain itu, pendekatan humanistik yang dikembangkan oleh Carl Rogers juga menjadi landasan penting dalam penggunaan refleksi dan parafrase. Pendekatan ini menekankan tiga prinsip utama:

1) empati (*empathy*),
2) penerimaan tanpa syarat (*unconditional positive regard*),
3) keaslian (*genuineness*).

Refleksi merupakan cara utama untuk menunjukkan empati, sedangkan parafrase membantu memperjelas komunikasi dan memastikan pemahaman yang akurat. Respons yang diberikan konselor harus bersifat tidak menghakimi serta mendukung perkembangan klien dalam memahami dirinya sendiri (Rogers, 1983; Corey, 2017).

C. Teknik Refleksi

Refleksi merupakan teknik konseling yang digunakan untuk mengungkapkan kembali perasaan, makna, dan pengalaman klien secara empatik. Teknik ini tidak hanya mengulang pernyataan klien, tetapi juga melibatkan pemahaman mendalam terhadap kondisi emosional yang mendasarinya. Refleksi membantu klien meningkatkan kesadaran diri serta memahami hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku (Egan, 2019).

1. Jenis-jenis Refleksi

1) **Refleksi Perasaan**

Berfokus pada emosi yang dirasakan klien, seperti sedih, marah, atau cemas.

2) **Refleksi Makna**

Berfokus pada arti atau nilai dari pengalaman yang dialami klien.

3) **Refleksi Implisit**

Menangkap pesan yang tidak diungkapkan secara langsung, seperti

kekhawatiran tersembunyi.

Penggunaan berbagai jenis refleksi memungkinkan konselor membantu klien memahami dirinya secara lebih mendalam (Corey, 2017) .

2. Langkah-langkah Melakukan Refleksi

1) **Mendengarkan secara aktif**

Konselor fokus pada pesan verbal dan nonverbal klien tanpa menyela.

2) **Mengidentifikasi emosi klien**

Konselor menangkap perasaan yang muncul, baik yang disampaikan secara langsung maupun tersirat.

3) **Mengungkapkan kembali secara empatik**

Konselor menyampaikan kembali perasaan klien dengan bahasa yang tepat.

4) **Menggunakan bahasa tentative**

Misalnya: *"Sepertinya Anda merasa…"*, agar klien tetap dapat mengoreksi.

Langkah-langkah ini membantu memastikan bahwa refleksi tidak bersifat menghakimi dan tetap berpusat pada klien.

3. Contoh Teknik Refleksi

1. Klien: *"Saya capek sekali dengan kondisi ini."*
   Konselor: *"Sepertinya Anda merasa lelah dan terbebani dengan situasi yang sedang dihadapi."*
2. Klien: *"Saya takut penyakit ini semakin parah."*
   Konselor: *"Anda merasa khawatir kondisi kesehatan Anda akan memburuk."*

Contoh ini menunjukkan bahwa refleksi berfokus pada **emosi**, bukan hanya isi pembicaraan.

D. Fungsi Refleksi

Refleksi memiliki beberapa fungsi penting dalam konseling, yaitu:

1. Validasi Perasaan

Refleksi membantu klien merasa bahwa perasaannya dipahami dan diterima.

2. Meningkatkan Kesadaran Diri

Klien terdorong untuk memahami emosi dan pengalaman secara lebih mendalam.

3. **Mengurangi Resistensi**

   Pendekatan empatik membuat klien lebih terbuka dan tidak defensif.

4. **Memperkuat Hubungan Terapeutik**

   Klien merasa dihargai sehingga hubungan konseling menjadi lebih kuat.

Refleksi juga berperan dalam meningkatkan motivasi perubahan perilaku, terutama dalam konteks promosi kesehatan. Pendekatan empatik terbukti mampu mengurangi resistensi dan meningkatkan kesiapan individu untuk berubah (Miller & Rollnick, 2013; Rogers, 1983)

E. Teknik Parafrase

Parafrase merupakan teknik konseling yang digunakan untuk menyampaikan kembali isi pembicaraan klien dengan bahasa yang lebih ringkas tanpa mengubah makna. Teknik ini berfokus pada konten atau isi pesan yang disampaikan oleh klien (Egan, 2019 . Prinsip Parafrase :

1. menjaga keakuratan makna,
2. menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas,
3. tidak menambahkan interpretasi berlebihan.

Parafrase yang baik biasanya lebih singkat dari pernyataan klien, tetapi tetap mencakup inti pesan. Teknik ini sangat membantu dalam menyederhanakan informasi yang kompleks sehingga lebih mudah dipahami (Corey, 2017). Langkah-langkah melakukan paraphrase:

1. **Mendengarkan isi pesan secara menyeluruh**

   Konselor memahami inti pembicaraan klien.

2. **Mengidentifikasi poin utama**

   Konselor memilih informasi penting dari cerita klien.

3. **Menyusun ulang dengan bahasa sendiri**

   Menggunakan kalimat yang lebih sederhana dan jelas.

4. **Memastikan kesesuaian makna**

   Konselor dapat menambahkan kalimat konfirmasi seperti: *"Apakah yang saya tangkap sudah benar?"*

F. Fungsi Parafrase

Parafrase memiliki beberapa fungsi utama dalam konseling, yaitu:

1. **Klarifikasi Pesan**

   Membantu memastikan bahwa konselor memahami pernyataan klien secara akurat.

2. **Mencegah Miskomunikasi**

   Mengurangi kemungkinan kesalahpahaman dalam komunikasi.

3. **Mengorganisasi Informasi**

   Membantu menyusun cerita klien agar lebih sistematis dan mudah dipahami.

4. **Menunjukkan Mendengarkan Aktif**

   Klien merasa didengarkan dan diperhatikan secara serius.

5. **Menjaga Alur Percakapan**

   Membantu menjaga fokus pembicaraan dalam sesi konseling.

Dengan demikian, parafrase tidak hanya berfungsi sebagai teknik komunikasi, tetapi juga sebagai strategi untuk meningkatkan efektivitas proses konseling secara keseluruhan (Egan, 2019; Corey, 2017)

G. Rangkuman

Refleksi dan parafrase merupakan keterampilan penting dalam konseling untuk memahami pengalaman klien secara empatik dan sistematis. Refleksi berfokus pada perasaan dan makna, sedangkan parafrase berfokus pada isi pembicaraan, sehingga keduanya saling melengkapi dalam proses komunikasi kesehatan.

H. Latihan / Evaluasi

1. Jelaskan perbedaan refleksi dan parafrase!
2. Sebutkan jenis-jenis refleksi!
3. Apa fungsi refleksi dalam konseling?
4. Jelaskan fungsi parafrase!
5. Mengapa teknik ini penting dalam promosi kesehatan?

BAB IX
TEKNIK MEMBANGUN RELASI INTERPERSONAL

A. Konsep dan Pentingnya Relasi Interpersonal

Relasi interpersonal merupakan hubungan komunikasi dua arah yang terjadi antara dua individu atau lebih yang melibatkan interaksi, pertukaran informasi, serta respons emosional. Dalam konteks konseling dan promosi kesehatan, relasi interpersonal tidak hanya sekadar komunikasi biasa, tetapi merupakan proses dinamis yang melibatkan empati, keterlibatan emosional, serta pemahaman terhadap pengalaman individu lain.

Relasi interpersonal menjadi dasar dalam membangun hubungan terapeutik yang efektif antara tenaga kesehatan dan klien. Hubungan yang baik memungkinkan pesan kesehatan disampaikan secara lebih personal dan mudah diterima oleh klien. Dengan demikian, relasi interpersonal berperan penting dalam meningkatkan efektivitas komunikasi serta mendukung perubahan perilaku kesehatan (DeVito, 2016).

B. Karakteristik Relasi Interpersonal

1. Komunikasi Dua Arah

Relasi interpersonal bersifat dua arah (*two-way communication*), yaitu terjadi pertukaran pesan secara aktif antara konselor dan klien. Klien tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan aktif dalam menyampaikan pengalaman dan perasaannya.

2. Melibatkan Aspek Kognitif dan Emosional

Relasi interpersonal tidak hanya mencakup pertukaran informasi (kognitif), tetapi juga melibatkan emosi (afektif). Hal ini penting karena dalam konseling kesehatan, emosi sering kali memengaruhi perilaku individu (DeVito, 2016) .

3. Adanya Kepercayaan

Kepercayaan merupakan fondasi utama dalam relasi interpersonal. Kepercayaan dibangun melalui sikap jujur, konsisten, dan empatik dari konselor. Tanpa kepercayaan, klien akan sulit membuka diri secara jujur.

4. Bersifat Dinamis dan Berkembang

Relasi interpersonal bersifat dinamis, artinya dapat berkembang seiring

waktu. Hubungan yang awalnya formal dapat menjadi lebih terbuka dan mendalam apabila komunikasi berjalan dengan baik (Corey, 2017)

C. Prinsip Dasar Relasi Interpersonal

1. **Empati**

   Empati merupakan kemampuan memahami perasaan dan perspektif klien tanpa menghakimi. Empati menjadi dasar dalam membangun hubungan yang hangat dan suportif (Rogers, 1983) .

2. **Menghargai Otonomi Klien**

   Konselor harus menghormati hak klien untuk mengambil keputusan sendiri tanpa tekanan. Hal ini penting dalam pendekatan promosi kesehatan yang berorientasi pada pemberdayaan individu.

3. **Kolaborasi (*Partnership*)**

   Konselor dan klien bekerja sama sebagai mitra dalam proses perubahan. Konselor tidak mendominasi, melainkan memfasilitasi klien dalam menemukan solusi.

4. **Keaslian (*Authenticity*)**

   Konselor harus bersikap jujur, tulus, dan tidak berpura-pura. Sikap ini membantu membangun kepercayaan dalam hubungan terapeutik.

5. ***Non-Judgmental***

   Konselor tidak boleh menghakimi klien. Sikap ini penting agar klien merasa aman untuk mengungkapkan masalahnya (Corey, 2017)

D. Teknik Membangun Relasi Interpersonal

1. ***Active Listening***

   Mendengarkan aktif merupakan teknik utama dalam membangun relasi interpersonal. Konselor memberikan perhatian penuh terhadap pesan verbal dan nonverbal klien sehingga klien merasa dihargai (Egan, 2019) .

2. **Refleksi dan Parafrase**

   Teknik ini digunakan untuk menunjukkan pemahaman terhadap perasaan dan isi pembicaraan klien. Refleksi berfokus pada emosi, sedangkan parafrase berfokus pada isi pesan.

3. **Pertanyaan Terbuka**

Pertanyaan terbuka (*open-ended questions*) memungkinkan klien menjelaskan pengalaman secara lebih mendalam. Teknik ini mendorong eksplorasi masalah secara komprehensif.

4. **Afirmasi**

   Afirmasi digunakan untuk memberikan penguatan positif terhadap usaha dan kekuatan klien, sehingga meningkatkan kepercayaan diri.

5. **Ringkasan (Summarizing)**

   Ringkasan membantu mengorganisasi informasi dan memastikan kesamaan pemahaman antara konselor dan klien.

Penggunaan teknik-teknik ini secara konsisten dapat meningkatkan kualitas hubungan interpersonal serta efektivitas komunikasi dalam konseling (Miller & Rollnick, 2013) .

E. Tahapan Membangun Relasi Interpersonal

1. Tahap Orientasi

   Tahap awal di mana konselor dan klien saling mengenal serta membangun kepercayaan. Konselor menciptakan suasana yang aman dan nyaman.

2. **Tahap Eksplorasi**

   Klien mulai mengungkapkan masalah dan pengalaman. Konselor berperan dalam mendengarkan secara aktif.

3. **Tahap Kerja (Working Stage)**

   Konselor dan klien bekerja sama mencari solusi dan mendorong perubahan perilaku.

4. **Tahap Terminasi**

   Tahap akhir untuk mengevaluasi hasil konseling dan mengakhiri hubungan secara profesional (Corey, 2017)

F. Faktor Pendukung dan Penghambat

1. **Faktor Pendukung**

   1) keterampilan komunikasi yang baik,
   2) adanya kepercayaan,
   3) kesamaan persepsi atau nilai,
   4) lingkungan yang nyaman dan kondusif.

   Faktor-faktor ini membantu menciptakan suasana yang aman sehingga klien

lebih terbuka dalam proses konseling (Glanz et al., 2015) .

2. Faktor Penghambat

1) sikap menghakimi dari konselor,
2) perbedaan budaya atau bahasa,
3) kurangnya keterampilan komunikasi,
4) hambatan emosional seperti kecemasan atau ketidakpercayaan.

Faktor-faktor ini dapat menghambat terbentuknya relasi interpersonal yang efektif (DeVito, 2016

G. Penerapan dalam Promosi Kesehatan

1. Konseling Kesehatan

Relasi interpersonal yang baik memungkinkan klien merasa nyaman untuk membahas masalah kesehatan yang sensitif. Hal ini meningkatkan efektivitas intervensi kesehatan (Notoatmodjo, 2012) .

2. Edukasi Individu dan Keluarga

Relasi interpersonal membantu tenaga kesehatan menyampaikan informasi secara lebih personal dan sesuai kebutuhan sasaran.

3. Pendampingan Perubahan Perilaku

Hubungan yang kuat meningkatkan motivasi dan komitmen klien dalam melakukan perubahan perilaku sehat.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Relasi interpersonal penting dalam membangun kepercayaan dan kerja sama dengan masyarakat dalam program kesehatan (Glanz et al., 2015)

H. Rangkuman

Relasi interpersonal merupakan dasar dalam komunikasi promosi kesehatan yang efektif. Dengan prinsip empati, kolaborasi, dan komunikasi yang tepat, hubungan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan, keterbukaan, dan keberhasilan perubahan perilaku kesehatan.

I. Latihan / Evaluasi

1. Jelaskan pengertian relasi interpersonal!
2. Mengapa relasi interpersonal penting dalam promosi kesehatan?
3. Sebutkan prinsip dasar membangun relasi interpersonal!

4. Apa saja teknik membangun relasi interpersonal?
5. Sebutkan faktor penghambat relasi interpersonal!

BAB X
KOMUNIKASI PERSUASIF

A. Konsep Komunikasi Persuasif

Komunikasi persuasif merupakan proses penyampaian pesan yang bertujuan memengaruhi sikap, pendapat, atau perilaku seseorang tanpa paksaan. Dalam konteks promosi kesehatan, komunikasi persuasif digunakan untuk mendorong individu dan kelompok mengadopsi perilaku hidup sehat, seperti berhenti merokok, melakukan imunisasi, dan menjaga pola makan sehat. Pendekatan ini menekankan penggunaan pesan yang logis, emosional, dan relevan agar dapat diterima dengan baik oleh audiens. Komunikasi persuasif tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap positif dan mendorong perubahan perilaku secara sukarela dan berkelanjutan (Perloff, 2017). Oleh karena itu, komunikasi persuasif menjadi strategi penting dalam promosi kesehatan karena mampu menjembatani antara informasi kesehatan dan tindakan nyata masyarakat.

B. Prinsip Dasar Komunikasi Persuasif

1. Kredibilitas Komunikator

Kredibilitas komunikator mencerminkan tingkat kepercayaan audiens terhadap sumber pesan. Komunikator yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kejujuran akan lebih mudah memengaruhi audiens.

2. Berorientasi pada Audiens (Audience-Centered

Komunikasi harus disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, dan latar belakang audiens. Pendekatan ini penting agar pesan lebih relevan dan mudah diterima.

3. Penyajian Pesan (Message Framing)

Cara penyajian pesan, baik secara positif maupun negatif, memengaruhi respons audiens. Pesan yang tepat akan meningkatkan efektivitas persuasi.

4. Komunikasi Dua Arah

Komunikasi dua arah memungkinkan adanya umpan balik sehingga pesan dapat dipahami dengan lebih baik dan terjadi interaksi yang lebih aktif.

5. Daya Tarik Emosional dan Rasional

Pesan yang menggabungkan aspek emosional dan rasional lebih efektif.

Emosi menyentuh perasaan audiens, sedangkan rasional memberikan dasar logis.

6. **Konsistensi Pesan**

Penyampaian pesan yang konsisten penting untuk membangun kepercayaan dan memperkuat pengaruh komunikasi.

C. Teknik-Teknik Komunikasi Persuasif

1. **Teknik AIDA (*Attention, Interest, Desire, Action*)**

Teknik AIDA merupakan pendekatan sistematis dalam memengaruhi perilaku audiens melalui empat tahap: menarik perhatian, membangun minat, menciptakan keinginan, dan mendorong tindakan. Dalam promosi kesehatan, teknik ini sering digunakan dalam kampanye seperti vaksinasi dan berhenti merokok karena mampu mengarahkan audiens secara bertahap menuju perubahan perilaku.

2. ***Storytelling***

Storytelling menggunakan cerita sebagai media penyampaian pesan sehingga lebih mudah dipahami dan diingat. Cerita yang relevan dengan kehidupan audiens dapat meningkatkan keterlibatan emosional dan empati. Dalam konteks kesehatan, *storytelling* efektif untuk menggambarkan dampak nyata suatu perilaku, sehingga mendorong perubahan perilaku.

3. ***Fear Appeal***

Fear appeal memanfaatkan rasa takut terhadap konsekuensi negatif untuk mendorong perubahan perilaku. Teknik ini sering digunakan dalam kampanye kesehatan, seperti bahaya merokok. Namun, penggunaannya harus proporsional karena jika berlebihan dapat menimbulkan kecemasan atau penolakan dari audiens.

4. ***Social Proof***

Social proof memanfaatkan pengaruh sosial dengan menunjukkan bahwa banyak orang telah melakukan perilaku tertentu. Dalam promosi kesehatan, teknik ini dapat meningkatkan kepercayaan dan mendorong audiens mengikuti perilaku sehat yang dilakukan oleh orang lain.

5. ***Authority***

Teknik *authority* menggunakan figur yang memiliki keahlian atau otoritas, seperti tenaga kesehatan atau tokoh masyarakat. Audiens cenderung lebih percaya

terhadap informasi yang disampaikan oleh sumber yang kredibel.

6. ***Reciprocity***

   Reciprocity didasarkan pada kecenderungan seseorang untuk membalas kebaikan. Dalam promosi kesehatan, teknik ini dapat dilakukan dengan memberikan manfaat terlebih dahulu, seperti edukasi atau layanan kesehatan gratis, sehingga audiens terdorong memberikan respons positif.

7. ***Foot-in-the-Door***

   Teknik ini dilakukan dengan meminta tindakan kecil terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan permintaan yang lebih besar. Pendekatan ini efektif dalam membangun perubahan perilaku secara bertahap dan berkelanjutan.

8. ***Motivational Interviewing***

   Motivational interviewing merupakan teknik komunikasi yang berfokus pada penggalian motivasi internal individu untuk berubah. Pendekatan ini bersifat kolaboratif, empatik, dan menghargai otonomi individu, sehingga sangat relevan dalam promosi kesehatan untuk mendorong perubahan perilaku jangka panjang.

D. Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Persuasi

1. **Faktor Komunikator**

   Kredibilitas, keahlian, dan kemampuan komunikasi sangat memengaruhi keberhasilan persuasi.

2. **Faktor Pesan**

   Pesan harus jelas, relevan, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan audiens agar mudah dipahami dan diterima.

3. **Faktor Audiens**

   Karakteristik audiens, seperti usia, pendidikan, budaya, dan pengalaman, memengaruhi cara mereka menerima informasi.

4. **Faktor Media**

   Pemilihan media harus disesuaikan dengan kondisi audiens, baik melalui komunikasi langsung maupun media digital.

5. **Faktor Situasional**

   Lingkungan, waktu, dan kondisi emosional audiens juga memengaruhi efektivitas komunikasi persuasif.

E. Rangkuman

Komunikasi persuasif merupakan proses komunikasi yang bertujuan memengaruhi sikap, keyakinan, dan perilaku tanpa paksaan melalui pendekatan psikologis dan komunikasi yang efektif. Dalam konteks kesehatan, komunikasi ini sangat penting untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat. Keberhasilan komunikasi persuasif dipengaruhi oleh kredibilitas komunikator, kesesuaian pesan dengan audiens, penggunaan teknik yang tepat, serta interaksi dua arah. Berbagai teknik seperti AIDA, storytelling, dan motivational interviewing dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pesan.

F. Latihan / Evaluasi

1. Jelaskan pengertian komunikasi persuasif dan tujuannya dalam promosi kesehatan!
2. Sebutkan dan jelaskan prinsip dasar komunikasi persuasif!
3. Berikan contoh penerapan teknik komunikasi persuasif dalam kehidupan sehari-hari!
4. Analisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan komunikasi persuasif!
5. Buatlah contoh pesan persuasif dalam bidang kesehatan!

BAB XI
TEORI PERUBAHAN PERILAKU KESEHATAN

A. Konsep Perubahan Perilaku

Perubahan perilaku merupakan proses dinamis yang menggambarkan pergeseran tindakan individu dari perilaku tidak sehat menuju perilaku yang lebih sehat. Proses ini tidak terjadi secara instan, tetapi melalui tahapan yang berurutan dan saling berkaitan, yaitu kesadaran (*awareness*), ketertarikan (*interest*), pertimbangan (*evaluation*), percobaan (*trial*), hingga adopsi (*adoption*) (Notoatmodjo, 2012). Dalam konteks promosi kesehatan, perubahan perilaku menjadi tujuan utama karena peningkatan pengetahuan tanpa diikuti perubahan tindakan tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap derajat kesehatan masyarakat (Green & Kreuter, 2005). Oleh karena itu, intervensi kesehatan harus dirancang tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan.

Green & Kreuter, 2005 dalam model PRECEDE-PROCEED mengelompokkan faktor yang mempengaruhi perilaku menjadi tiga kategori utama (Green & Kreuter, 2005):

1. **Faktor Predisposisi**

   Faktor predisposisi berasal dari dalam diri individu, seperti pengetahuan, sikap, nilai, kepercayaan, dan persepsi. Faktor ini menentukan kesiapan individu untuk melakukan perubahan perilaku.

2. Faktor Pendukung (Enabling Factors)

   Faktor pendukung merupakan kondisi yang memfasilitasi terjadinya perilaku, seperti ketersediaan sarana, akses layanan kesehatan, serta kebijakan

yang mendukung. Tanpa faktor ini, individu mungkin memiliki niat, tetapi tidak mampu melakukan perubahan.

3. Faktor Penguat (Reinforcing Factors)

Faktor penguat berkaitan dengan dukungan sosial, seperti keluarga, teman, tokoh masyarakat, dan tenaga kesehatan. Dukungan ini berperan dalam memperkuat dan mempertahankan perilaku sehat dalam jangka panjang. Ketiga faktor tersebut saling berinteraksi sehingga intervensi promosi kesehatan harus mempertimbangkan seluruh aspek agar lebih efektif (Green & Kreuter, 2005).

B. Teori Perubahan Perilaku

1. Health Belief Model (HBM)

Health Belief Model menjelaskan bahwa perilaku kesehatan dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap kerentanan, keparahan, manfaat, dan hambatan, serta didukung oleh *self-efficacy*. Dalam konteks promosi kesehatan di Indonesia, berbagai penelitian menunjukkan bahwa persepsi risiko dan manfaat sangat memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap perilaku kesehatan, seperti penggunaan masker, vaksinasi, dan pencegahan penyakit menular. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan, tetapi juga oleh persepsi individu terhadap situasi yang dihadapi. Penerapan HBM banyak digunakan dalam program vaksinasi dan pencegahan penyakit, di mana tenaga kesehatan memberikan edukasi mengenai risiko penyakit, manfaat tindakan, serta mengurangi hambatan yang dirasakan masyarakat .

2. Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh niat (*intention*), yang terbentuk dari sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku (Ajzen, 1991). Dalam konteks promosi kesehatan, sikap positif terhadap perilaku sehat, dukungan sosial, serta keyakinan terhadap kemampuan diri terbukti meningkatkan niat dan perilaku kesehatan. Oleh karena itu, intervensi kesehatan perlu memperkuat ketiga komponen tersebut agar perubahan perilaku

dapat terjadi secara optimal .

3. **Transtheoretical Model (TTM)**

Transtheoretical Model menjelaskan bahwa perubahan perilaku terjadi melalui tahapan bertahap, yaitu *precontemplation, contemplation, preparation, action,* dan *maintenance* (Prochaska & DiClemente, 1983). Pendekatan ini menekankan bahwa setiap individu berada pada tahap kesiapan yang berbeda, sehingga intervensi harus disesuaikan dengan tahap tersebut. Dalam promosi kesehatan, pendekatan ini efektif untuk program berhenti merokok, diet sehat, dan aktivitas fisik karena lebih tepat sasaran.

4. **Social Cognitive Theory (SCT)**

Social Cognitive Theory menekankan bahwa perilaku dipengaruhi oleh interaksi antara individu, lingkungan, dan perilaku itu sendiri (*reciprocal determinism*), serta pentingnya *self-efficacy* dalam perubahan perilaku (Bandura, 1986). Dalam praktik promosi kesehatan, peningkatan kepercayaan diri individu serta dukungan sosial terbukti berperan penting dalam keberhasilan perubahan perilaku, terutama dalam pengelolaan penyakit kronis dan pencegahan masalah kesehatan

C. Strategi Promosi Kesehatan

Strategi promosi kesehatan merupakan pendekatan sistematis untuk meningkatkan kemampuan individu dan masyarakat dalam menjaga kesehatan melalui perubahan perilaku dan lingkungan yang mendukung. Promosi kesehatan tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat agar mampu mengambil keputusan yang tepat (WHO, 1986) .

1. **Pendekatan Berbasis Sasaran (Audience-Centered)**

Strategi ini menyesuaikan pesan kesehatan dengan karakteristik sasaran, seperti usia, pendidikan, budaya, dan kebutuhan. Penyesuaian ini penting agar pesan lebih relevan dan mudah diterima (Notoatmodjo, 2012) .

2. **Pemilihan Media yang Tepat**

Media komunikasi dapat berupa komunikasi langsung (konseling, penyuluhan) maupun tidak langsung (poster, media sosial, televisi). Pemilihan media harus disesuaikan dengan tujuan dan kondisi sasaran agar lebih efektif (Glanz et al., 2015) .

3. **Pendekatan Persuasif dan Partisipatif**

   Pendekatan persuasif bertujuan memengaruhi sikap dan perilaku, sedangkan pendekatan partisipatif melibatkan masyarakat secara aktif. Keterlibatan masyarakat penting untuk meningkatkan keberlanjutan perubahan perilaku (Green & Kreuter, 2005) .

4. **Pemanfaatan Sumber Kredibel**

   Tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan pemimpin agama merupakan sumber informasi yang dipercaya. Kredibilitas sumber meningkatkan kemungkinan pesan diterima dan diikuti (Notoatmodjo, 2012) .

5. **Evaluasi Program**

   Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan program melalui perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan program di masa mendatang (Glanz et al., 2015).

D. Rangkuman

Promosi kesehatan bertujuan mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih sehat melalui pendekatan komunikasi, edukasi, dan pemberdayaan. Perubahan perilaku dipengaruhi oleh berbagai faktor serta teori seperti HBM, TPB, TTM, dan SCT. Keberhasilan promosi kesehatan didukung oleh relasi interpersonal yang baik, teknik komunikasi efektif, serta strategi yang tepat sesuai karakteristik sasaran.

E. Latihan / Evaluasi

1. Jelaskan pengertian perubahan perilaku dalam konteks promosi kesehatan!
2. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kesehatan!
3. Jelaskan perbedaan antara Health Belief Model (HBM) dan Theory of Planned Behavior (TPB)!
4. Apa yang dimaksud dengan tahapan perubahan dalam Transtheoretical Model (TTM)?
5. Jelaskan konsep self-efficacy dalam Social Cognitive Theory!

BAB XIII
KOMUNIKASI KELOMPOK RENTAN

A. Konsep Kelompok Rentan Dalam Kesehatan Masyarakat

Dalam konteks kesehatan masyarakat, kelompok rentan merupakan kelompok yang memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami gangguan kesehatan akibat keterbatasan dalam akses sumber daya, informasi, maupun pelayanan kesehatan. Kerentanan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh kondisi struktural seperti ketimpangan sosial dan ekonomi. Nutbeam (2000) menegaskan bahwa rendahnya literasi kesehatan menjadi salah satu indikator utama yang meningkatkan kerentanan, karena individu kesulitan memahami informasi kesehatan dan mengambil keputusan yang tepat.

Kelompok rentan mencakup berbagai kategori, antara lain anak-anak, lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, serta kelompok dengan penyakit kronis atau kondisi tertentu. Selain itu, kelompok yang mengalami marginalisasi sosial, seperti penderita HIV/AIDS, pengguna narkoba, atau individu dengan gangguan kesehatan mental, juga termasuk dalam kelompok rentan karena sering menghadapi stigma dan diskriminasi (WHO, 1986). Kerentanan sering kali bersifat multidimensional, sehingga memerlukan pendekatan yang komprehensif dalam edukasi kesehatan.

B. Faktor Kerentanan (Sosial, Ekonomi, Kesehatan, Stigma)

Kerentanan dalam kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor. Faktor sosial, seperti tingkat pendidikan, norma budaya, dan lingkungan sosial, berperan dalam menentukan bagaimana individu memahami dan merespons informasi kesehatan. Individu dengan pendidikan rendah cenderung memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi yang valid.

Faktor ekonomi juga sangat berpengaruh, karena keterbatasan finansial dapat menghambat akses terhadap pelayanan kesehatan, makanan bergizi, serta lingkungan yang sehat. Menurut penelitian oleh Glanz et al. (2008), kondisi sosial ekonomi yang rendah berkorelasi dengan tingginya risiko penyakit dan rendahnya perilaku hidup sehat.

Selain itu, faktor kesehatan seperti penyakit kronis, disabilitas, dan usia lanjut

meningkatkan kebutuhan akan pendekatan edukasi yang lebih spesifik. Stigma sosial menjadi faktor yang sangat signifikan, terutama pada penyakit tertentu seperti HIV/AIDS atau gangguan mental. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa stigma dapat menghambat individu untuk mencari pengobatan maupun menerima edukasi kesehatan (Sari et al., 2020).

C. Prinsip Komunikasi pada Kelompok Rentan

Komunikasi dalam edukasi kesehatan pada kelompok rentan harus dilakukan dengan pendekatan yang sederhana, jelas, dan kontekstual. Informasi kesehatan perlu disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami serta disesuaikan dengan latar belakang sasaran. Kreps dan Thornton (1992) menekankan bahwa komunikasi kesehatan yang efektif harus mampu membangun hubungan interpersonal yang baik agar pesan dapat diterima dengan optimal.

Selain itu, komunikasi harus bersifat partisipatif dan dialogis, bukan sekadar penyampaian informasi satu arah. Pendekatan ini memungkinkan sasaran untuk terlibat aktif, mengajukan pertanyaan, serta mengaitkan informasi dengan pengalaman mereka sendiri. Sensitivitas budaya juga menjadi prinsip penting, di mana tenaga kesehatan harus memahami nilai dan kepercayaan masyarakat agar pesan tidak bertentangan dengan budaya setempat.

1. Empati *dan Respect*

Empati dalam komunikasi kesehatan merupakan kemampuan untuk memahami kondisi emosional dan sosial sasaran, sedangkan respect berkaitan dengan sikap menghargai setiap individu tanpa diskriminasi. Pendekatan ini sangat penting dalam membangun kepercayaan, terutama pada kelompok rentan yang sering mengalami stigma atau marginalisasi.

Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang berbasis empati dapat meningkatkan keterbukaan pasien dan kepatuhan terhadap anjuran kesehatan (Derksen et al., 2013). Dengan menunjukkan empati, tenaga kesehatan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan dukungan emosional yang dapat memperkuat motivasi perubahan perilaku.

2. *Non-Judgmental Communication*

Komunikasi yang tidak menghakimi (*non-judgmental communication*) merupakan prinsip penting dalam edukasi kesehatan. Pendekatan ini menghindari

penggunaan bahasa yang menyalahkan, mengkritik, atau merendahkan sasaran. Sebaliknya, komunikasi difokuskan pada solusi dan dukungan.

Menurut Miller dan Rollnick (2013) dalam pendekatan *motivational interviewing*, komunikasi yang tidak menghakimi terbukti efektif dalam membantu individu mengubah perilaku, karena menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Dalam konteks kelompok rentan, pendekatan ini sangat penting untuk mengurangi hambatan psikologis dan meningkatkan keterbukaan.

D. Strategi Komunikasi pada Beberapa Kelompok Rentan

Strategi komunikasi harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kelompok. Pada anak-anak, pendekatan visual dan permainan edukatif lebih efektif karena sesuai dengan tahap perkembangan kognitif mereka. Pada lansia, komunikasi harus dilakukan secara perlahan dengan mempertimbangkan keterbatasan fisik seperti pendengaran dan penglihatan.

Pada masyarakat dengan pendidikan rendah, pesan kesehatan harus disampaikan secara praktis dan sederhana, serta dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Sementara itu, pada kelompok yang mengalami stigma, seperti penderita HIV/AIDS, pendekatan komunikasi harus lebih sensitif, menjaga kerahasiaan, dan membangun kepercayaan (WHO, 1986).

Penelitian di Indonesia juga menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi berbasis budaya lokal lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan pesan kesehatan di masyarakat (Kurniawan et al., 2019).

E. Contoh Kasus Pendekatan Verbal dalam Edukasi Promosi Kesehatan

Pendekatan verbal dalam edukasi kesehatan sangat menentukan keberhasilan komunikasi, terutama pada kelompok rentan. Sebagai contoh, dalam kasus seorang ibu dengan anak yang mengalami gizi kurang, pendekatan komunikasi yang menyalahkan seperti “Ibu tidak merawat anak dengan baik” dapat menimbulkan resistensi dan penolakan. Sebaliknya, pendekatan yang empatik dan tidak menghakimi, seperti “Mari kita cari bersama cara agar kebutuhan gizi anak bisa terpenuhi sesuai kondisi keluarga,” akan lebih efektif dalam membangun hubungan yang positif.

Penelitian internasional menunjukkan bahwa komunikasi berbasis empati dan non-judgmental dapat meningkatkan kepatuhan terhadap intervensi kesehatan

dan memperbaiki hasil kesehatan pasien (Derksen et al., 2013). Sementara itu, penelitian di Indonesia oleh Sari et al. (2020) menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi yang menghargai dan tidak menghakimi pada pasien HIV/AIDS dapat meningkatkan keterbukaan pasien dalam menerima edukasi dan menjalani pengobatan.

Contoh lain dapat dilihat pada edukasi pasien penyakit kronis seperti diabetes. Pendekatan verbal yang menekankan dukungan, seperti memberikan motivasi dan solusi yang realistis, terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan yang bersifat mengkritik. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang baik tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga membangun hubungan yang mendukung perubahan perilaku.

F. Rangkuman

Kelompok rentan dalam kesehatan masyarakat merupakan kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi terhadap masalah kesehatan akibat berbagai faktor seperti sosial, ekonomi, kondisi kesehatan, dan stigma. Oleh karena itu, edukasi promosi kesehatan pada kelompok ini memerlukan pendekatan komunikasi yang khusus dan sensitif. Prinsip komunikasi yang efektif meliputi penggunaan bahasa yang sederhana, sikap empatik, penghormatan terhadap sasaran, serta komunikasi yang tidak menghakimi. Selain itu, strategi komunikasi harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kelompok agar pesan kesehatan dapat diterima dengan baik. Keberhasilan edukasi kesehatan sangat ditentukan oleh kemampuan tenaga kesehatan dalam membangun hubungan interpersonal yang baik serta menyampaikan pesan secara tepat dan kontekstual.

G. Latihan / Evaluasi

1. Jelaskan konsep kelompok rentan dalam kesehatan masyarakat!
2. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kerentanan!
3. Mengapa empati penting dalam edukasi kesehatan?
4. Jelaskan prinsip komunikasi non-judgmental!
5. Berikan contoh strategi komunikasi pada salah satu kelompok rentan!

BAB XIV
APLIKASI EDUKASI DAN KONSELING DALAM PROMOSI KESEHATAN

A. Orientasi Aplikasi Edukasi dan Konseling

Dalam praktik promosi kesehatan, edukasi dan konseling tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi, tetapi juga mendorong perubahan perilaku kesehatan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan lapangan harus berorientasi pada perubahan perilaku yang spesifik sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Mahasiswa perlu memahami bahwa fokus utama kegiatan meliputi:

1. perubahan perilaku sasaran,
2. pendekatan berbasis karakteristik masyarakat, dan
3. pemberdayaan masyarakat agar mampu menjaga kesehatannya secara mandiri.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip promosi kesehatan yang menekankan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat (WHO, 1986) .

B. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan fondasi dalam kegiatan edukasi dan konseling karena menentukan arah dan efektivitas intervensi. Kegiatan diawali dengan identifikasi masalah kesehatan berdasarkan data yang telah diperoleh sebelumnya, baik dari laporan kesehatan, observasi, maupun wawancara. Tahap ini bertujuan memastikan bahwa intervensi yang dilakukan bersifat spesifik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Notoatmodjo, 2012) . Selanjutnya, mahasiswa menentukan sasaran kegiatan, yang dapat berupa individu, keluarga, atau kelompok. Penentuan sasaran harus disertai analisis karakteristik, seperti usia, pendidikan, budaya, dan tingkat pengetahuan. Analisis ini penting untuk menentukan pendekatan komunikasi yang tepat.

Tahap berikutnya adalah perumusan tujuan edukasi dan konseling yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku. Tujuan yang jelas akan memudahkan dalam penyusunan materi, pemilihan metode, serta evaluasi kegiatan. Materi edukasi disusun secara sistematis, sederhana, dan aplikatif. Selain itu, mahasiswa perlu menyiapkan media dan alat bantu yang sesuai, seperti leaflet, poster, atau alat peraga, guna meningkatkan efektivitas penyampaian pesan (Glanz

et al., 2015) .

C. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan inti kegiatan, di mana edukasi dan konseling diterapkan secara langsung kepada masyarakat.

1. **Penyampaian Edukasi**

   Edukasi dilakukan dengan menyampaikan informasi kesehatan secara jelas, sederhana, dan relevan. Bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman sasaran. Penggunaan media sangat dianjurkan untuk meningkatkan pemahaman dan daya ingat.Edukasi harus bersifat interaktif dengan melibatkan masyarakat melalui diskusi dan tanya jawab agar proses belajar menjadi lebih efektif (Glanz et al., 2015) .

2. **Pelaksanaan Konseling**

   Konseling dilakukan sebagai pendekatan yang lebih personal untuk membantu individu memahami masalah serta mendorong perubahan perilaku. Proses konseling diawali dengan membangun hubungan (rapport), kemudian dilanjutkan dengan eksplorasi masalah melalui komunikasi empatik dan mendengarkan aktif. Konselor memberikan informasi yang relevan serta membantu individu mempertimbangkan solusi tanpa memaksakan keputusan (Corey, 2017) .

3. **Penerapan Komunikasi Efektif**

   Keberhasilan pelaksanaan sangat ditentukan oleh kemampuan komunikasi mahasiswa. Komunikasi harus dilakukan secara jelas, sederhana, dan tidak menghakimi. Selain itu, komunikasi dua arah perlu diutamakan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif. Penggunaan teknik seperti pertanyaan terbuka, refleksi, dan parafrase dapat membantu memahami kondisi sasaran secara lebih mendalam

D. Prinsip Pelaksanaan

Pelaksanaan edukasi dan konseling harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

1. **Berorientasi pada perubahan perilaku**

Kegiatan tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi pada perubahan tindakan nyata.

2. **Berbasis kebutuhan Masyarakat**

   Intervensi harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sasaran.

3. **Partisipatif**

   Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses kegiatan.

4. **Menghargai nilai dan budaya**

   Pendekatan harus sesuai dengan norma sosial yang berlaku.

5. **Komunikasi empatik dan professional**

   Mahasiswa harus bersikap sopan, menghargai privasi, dan tidak menghakimi.

Penerapan prinsip-prinsip ini akan meningkatkan efektivitas intervensi dan keberlanjutan perubahan perilaku .

E. Langkah Operasional Pelaksanaan

Untuk mempermudah implementasi di lapangan, kegiatan dapat dilakukan melalui tahapan berikut:

1. membuka interaksi dengan membangun suasana yang nyaman,
2. menyampaikan edukasi sesuai tema,
3. melibatkan masyarakat secara aktif,
4. melakukan konseling pada sasaran tertentu,
5. menutup kegiatan dengan ringkasan dan pesan utama.

Tahapan ini menunjukkan bahwa edukasi dan konseling merupakan proses yang terintegrasi dalam promosi kesehatan

F. Hal yang Harus Dihindari

Dalam pelaksanaan kegiatan, mahasiswa perlu menghindari:

1. sikap menggurui atau memaksa,
2. penggunaan bahasa yang sulit dipahami,
3. komunikasi satu arah,
4. serta penyampaian materi yang tidak terfokus.

Kesalahan tersebut dapat menghambat efektivitas komunikasi dan menurunkan partisipasi masyarakat

G. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi merupakan tahap penting untuk menilai efektivitas kegiatan edukasi dan konseling. Evaluasi meliputi:

1. **evaluasi proses**, yaitu menilai pelaksanaan kegiatan dan partisipasi sasaran,
2. **evaluasi hasil**, yaitu menilai perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku.

Evaluasi juga bertujuan mengidentifikasi hambatan yang terjadi sehingga dapat menjadi dasar perbaikan kegiatan di masa mendatang (Green & Kreuter, 2005)

H. Indikator Keberhasilan

Kegiatan edukasi dan konseling dinyatakan berhasil apabila:

1. masyarakat memahami pesan yang disampaikan,
2. terjadi peningkatan kesadaran,
3. serta muncul niat atau tindakan untuk melakukan perubahan perilaku.

Keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah materi yang disampaikan, tetapi dari perubahan yang terjadi pada sasaran

I. Rangkuman

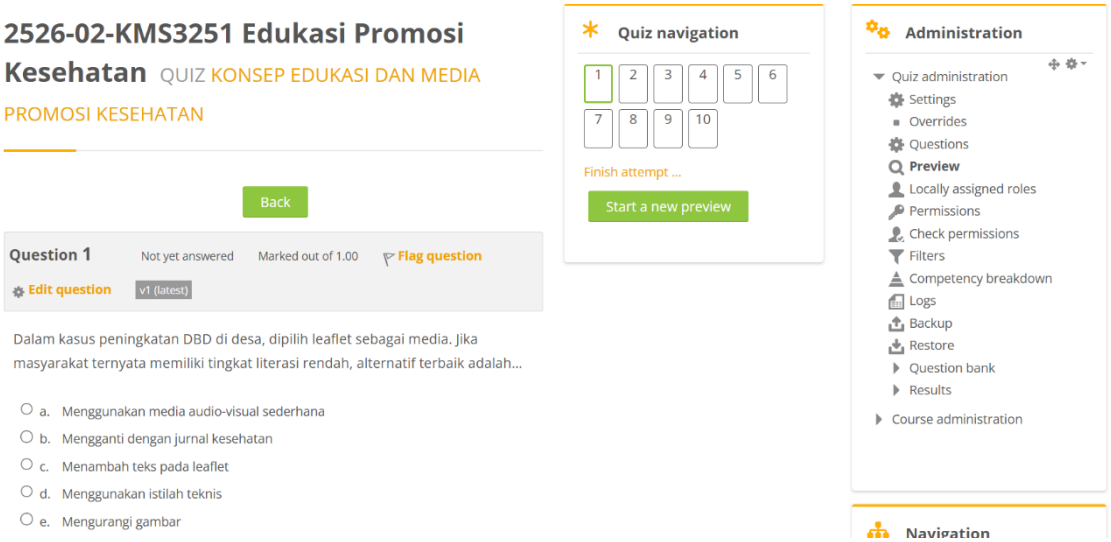
Edukasi dan konseling dalam promosi kesehatan bertujuan mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan motivasi internal. Pelaksanaannya dilakukan secara sistematis dengan komunikasi yang efektif, empatik, dan sesuai karakteristik sasaran, sehingga tidak hanya menyampaikan informasi tetapi menghasilkan perubahan perilaku nyata.

J. Latihan / Evaluasi

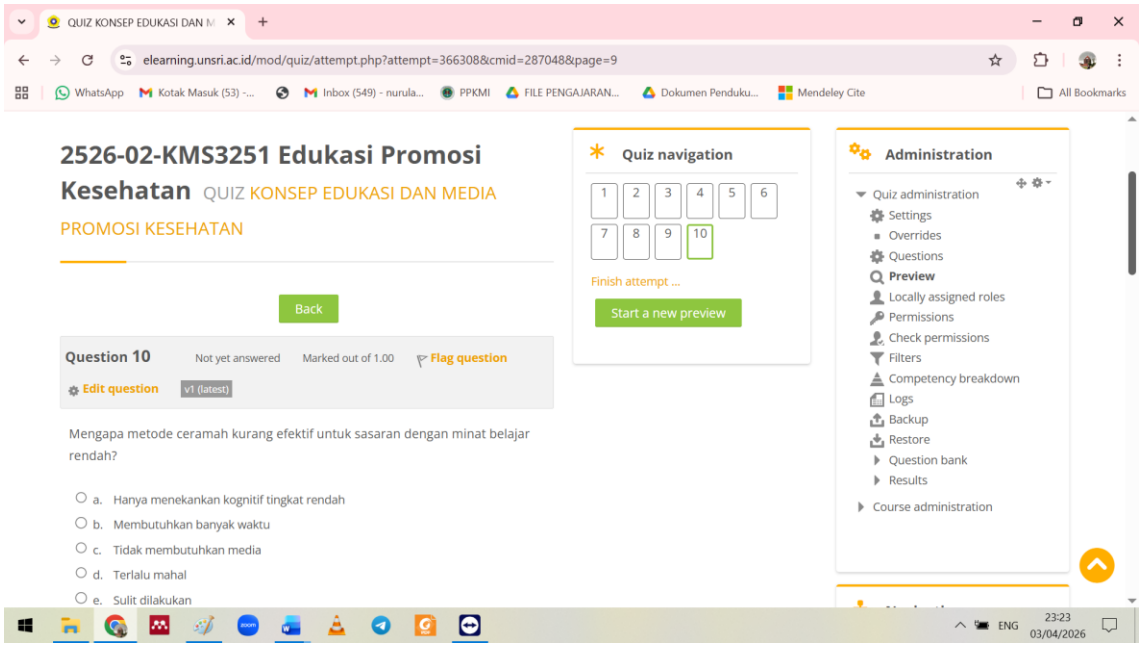
1. Jelaskan tujuan tahap persiapan dalam promosi kesehatan!
2. Mengapa analisis karakteristik sasaran penting dalam edukasi kesehatan?
3. Sebutkan metode yang dapat digunakan dalam edukasi kesehatan!
4. Apa perbedaan edukasi dan konseling kesehatan?
5. Mengapa komunikasi empatik penting dalam konseling?

BAB XV
CONTOH SOAL BESERTA JAWABAN

Berikut adalah contoh soal atau kuis yang terdapat pada pembelajaran mata kuliah Edukasi Promosi Kesehatan melalui *elearning* Universitas Sriwijaya yang ditampilkan pada:



Gambar 12. 1 Contoh Soal Atau Kuis



Gambar 12. 2 Gambar 12. 3 Contoh Soal Atau Kuis

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. (1991). *The theory of planned behavior.* https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/074959789190020T

American Counseling Association. (2014). *ACA code of ethics.* https://www.counseling.org/resources/aca-code-of-ethics.pdf

Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action.* https://archive.org/details/socialfoundation00band

Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2001). *Principles of biomedical ethics* (5th ed.). Oxford University Press

Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2013). *Principles of biomedical ethics* (7th ed.). Oxford University Press

Bloom, B. S. (1956). *Taxonomy of educational objectives.* Longmans

BMC Nursing. (2024). *Communication and clinical decision-making.* https://bmcnurs.biomedcentral.com

BMC Public Health. (2022). *Health communication and feedback.* https://bmcpublichealth.biomedcentral.com

Behavioral Sciences (MDPI). (2024). *Critical thinking in decision making.* https://www.mdpi.com/journal/behavsci

Brownell, J. (2012). *Listening: Attitudes, principles, and skills.* Pearson

Corey, G. (2017). *Theory and practice of counseling and psychotherapy.* Cengage Learning

Dale, E. (1969). *Audio-visual methods in teaching* (3rd ed.). Holt, Rinehart and Winston

DeVito, J. A. (2016). *The interpersonal communication book.* https://books.google.com

Egan, G. (2014). *The skilled helper.* Brooks/Cole

Egan, G. (2019). *The skilled helper.* https://books.google.com

Ellis, A. (2003). *Rational emotive behavior therapy.* https://albertellis.org

Facione, P. A. (2011). *Critical thinking: What it is and why it counts.* Insight Assessment

Frontiers in Public Health. (2024). *Communication in public health.* https://www.frontiersin.org

Frontiers in Public Health. (2025). *Community communication and listening.* https://www.frontiersin.org/journals/public-health

Glanz, K., Rimer, B. K., & Viswanath, K. (2015). *Health behavior: Theory, research,*

and practice. Jossey-Bass

Green, L. W., & Kreuter, M. W. (2005). *Health program planning: An educational and ecological approach* (4th ed.). McGraw-Hill

Hargie, O. (2011). *Skilled interpersonal communication.* Routledge

Health Promotion International. (2024). *Systems thinking in health promotion.*

Heliyon. (2023). *Critical thinking in health data analysis.* https://www.sciencedirect.com/journal/heliyon

Journal of Health Communication. (2023). *Health communication effectiveness.* https://www.tandfonline.com

Journal of Nonverbal Behavior. (2022). *Nonverbal communication in healthcare.* https://link.springer.com

Miller, W. R., & Rollnick, S. (2013). *Motivational interviewing: Helping people change* (3rd ed.). Guilford Press

Notoatmodjo, S. (2012). *Promosi kesehatan dan perilaku kesehatan.* Rineka Cipta

Patient Education and Counseling. (2021). *Communication and patient understanding.* https://www.sciencedirect.com

Perloff, R. M. (2017). *The dynamics of persuasion.* Routledge

PLOS ONE. (2024). *Critical thinking and health literacy.* https://journals.plos.org/plosone

Rogers, C. R. (1983). *Client-centered therapy.* Houghton Mifflin

Sadiman, A. S., Rahardjo, R., Haryono, A., & Harjito. (2011). *Media pendidikan.* Rajawali Pers

Schiavo, R. (2014). *Health communication: From theory to practice.* https://books.google.com

Scientific Reports. (2024). *Decision-making and critical thinking.* https://www.nature.com/srep

Skinner, B. F. (1953). *Science and human behavior.* https://archive.org

Sue, D. W., & Sue, D. (2016). *Counseling the culturally diverse.* Wiley

Welfel, E. R. (2016). *Ethics in counseling and psychotherapy.* Cengage Learning

World Health Organization. (1986). *Ottawa Charter for Health Promotion.* https://www.who.int/publications/i/item/ottawa-charter-for-health-promotion

World Health Organization. (2021). *Health communication.* https://www.who.int

LAMPIRAN